

LIBRO DOCENTE PARA RESIDENTES

Casos clínicos de dolor crónico

Cómo pregunta, interpreta, explora, decide y hace seguimiento un experto

Objetivo Aprender a conducir la consulta observando el razonamiento clínico, incluidas la incertidumbre, la no intervención y la revisión de una decisión cuando la evolución no concuerda.

Versión	Casos	Ámbito
2.0 · 13/07/2026	34 casos completos y comentados	Adultos · consulta especializada · formación supervisada

Límite Documento formativo. Las técnicas requieren acreditación, supervisión, imagen y protocolo local. No constituye una prescripción para un paciente concreto.

Cómo estudiar cada caso

1. Lea solo la presentación y escriba tres hipótesis y una alternativa peligrosa.
2. Tape la columna «Pensamiento clínico» y responda antes que el experto.
3. Antes de explorar, diga qué maniobra puede cambiar la probabilidad.
4. Defienda la decisión de intervenir o no intervenir.
5. Defina una actividad diana, un plazo y un criterio de salida.
6. Resuelva la evolución inesperada antes de leer la reflexión.

Regla El objetivo no es memorizar la respuesta del caso, sino reproducir el proceso: seguridad → problema → ALICIA-ABCDE → mecanismo → diferencial → exploración → certeza → plan → seguimiento.

Estructura mental de la consulta experta

Momento	Acción del residente	Producto antes de avanzar
1 · Encuadre	Agenda, preocupación y actividad diana	Objetivo basal medible
2 · Seguridad	Banderas neurológicas, infección, tumor, fractura y vascular	Circuito ordinario o urgente
3 · ALICIA	Aparición, Localización, Intensidad, Características, Irradiación, Agravantes/atenuantes	Fenotipo y mapa
4 · ABCDE	Anatomía, Biología/mecanismo, Cognicióncurso, Dolor/discapacidad, Entorno	Dominante y moduladores
5 · Hipótesis	Tres diagnósticos y una alternativa peligrosa	Dato a favor, en contra y faltante
6 · Exploración	Solo maniobras capaces de cambiar probabilidades	Concordancia o reformulación
7 · Plan	Base, fármaco, técnica si procede y plan B	Objetivo, dosis, salida y seguridad
8 · Cierre	Teach-back, alarmas y fecha	Paciente sabe qué hacer y cuándo volver

Banco breve de frases terapéuticas

Objetivo	Frase utilizable
Validar	«Le creo cuando dice que le duele; ahora vamos a descubrir qué mecanismos lo mantienen».
Priorizar	«Si hoy solo pudiéramos recuperar una actividad, ¿cuál cambiaría más su vida?».
Descentrar la imagen	«El desgaste de la imagen es una pista; necesitamos comprobar que coincide con su dolor y su exploración».
Explicar incertidumbre	«Tengo una hipótesis principal, pero quiero comprobar este dato antes de tratarla como certeza».
Enmarcar una técnica	«La infiltración no es el objetivo final: debe abrir una ventana para recuperar función».
Evitar promesas	«Buscamos una mejoría útil y medible, no garantizar dolor cero».
Negociar seguimiento	«Si esto funciona, espero que ocurra X en Y semanas; si no ocurre, no repetiremos por inercia».
Teach-back	«Explíqueme con sus palabras qué cree que ocurre y cuál es el siguiente paso».

Dosis orales de consulta rápida

Uso Son rangos docentes para adultos, no una prescripción individual. Confirmar ficha técnica española, indicación, edad, embarazo, riñón, hígado, sodio, intervalo QT (QT), caídas, interacciones y duplicidades.

Fármaco	Inicio/rango orientativo	Regla de seguimiento
Paracetamol	500-1.000 mg cada 8 h; máximo habitual 3 g/día, menor en fragilidad/hepatopatía	No mantener si no aporta función; contar combinaciones
Ibuprofeno	200-400 mg cada 8 h, curso corto	Riesgo gastrointestinal, renal y cardiovascular; no combinar antiinflamatorios
Naproxeno	250 mg cada 12 h; ajustar según ficha/respuesta	Mismo cribado y duración mínima
Duloxetina	30 mg/día 1-2 semanas; 60 mg/día si tolera	Náusea, presión arterial, sodio, hígado; retirada gradual
Amitriptilina	10 mg por la noche; rango habitual 10-50 mg	Carga anticolinérgica, intervalo QT (QT), retención, cognición y caídas
Gabapentina	100-300 mg noche; titular si indicada	Ajuste renal, sedación, edema; no usar rutinariamente para sciática
Pregabalina	25-75 mg noche o 75 mg cada 12 h; titular si indicada	Ajuste renal, edema, caídas/dependencia; retirada gradual
Lidocaína tópica 5%	Hasta 12 h/día sobre piel íntegra; máximo según ficha	Útil en dolor neuropático localizado; revisar piel

Parámetros técnicos de consulta rápida

Seis puertas Síndrome reconocible, concordancia, tratamiento base, objetivo, seguridad y plan de salida. Si una puerta está cerrada, no se compensa aumentando la dosis.

Técnica	Dosis/parámetros docentes	Límite/propósito
Bloqueo de rama medial lumbar	Lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%, 0,3-0,5 mL por diana; sin corticoide si pronóstico	Probar actividad durante ventana; seleccionar radiofrecuencia
Radiofrecuencia facetaria térmica	80-90 °C, 60-120 s por lesión, técnica validada	Solo tras bloqueo concordante; parámetros no sustituyen colocación
Epidural transforaminal lumbar	Lidocaína 1% 1 mL de prueba + dexametasona 4-10 mg; total habitual ≤4 mL	Contraste en tiempo real; radiculopatía concordante
Epidural interlaminar	Dexametasona 4-10 mg + suero/anestésico local bajo; 4-8 mL orientativo	Off-label; adaptar a nivel, anatomía y protocolo
Epidural caudal	Dexametasona 4-10 mg + suero; 10-20 mL lento, anestésico local bajo o ninguno	No rutinaria para claudicación por estenosis central
Radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal	Temperatura máxima 42 °C; 120 s a 6-12 min según protocolo	Evidencia heterogénea; no equivale a radiofrecuencia térmica

Técnica	Dosis/parámetros docentes	Límite/propósito
Hombro glenohumeral/bursa subacromial-subdeltoidea	Triamcinolona 20 mg + lidocaína 1% 2-4 mL	Ventana para rehabilitación; nunca intratendinoso
Cadera intraarticular	Triamcinolona 40 mg + lidocaína 1% 2-3 mL; total 3-5 mL	Guía por imagen; vigilar glucemia/infección
Rodilla intraarticular	Triamcinolona 40 mg + lidocaína 1% 2-4 mL	No en articulación caliente; beneficio corto
Sacroilíaca	Volumen intraarticular ≤2,5 mL; triamcinolona/metilprednisolona 40 mg terapéutica	Diagnóstica: anestésico local sin corticoide; guía fluoroscópica/tomografía computarizada (TC) preferente
Faceta intraarticular	Triamcinolona/metilprednisolona 10-20 mg si inflamación seleccionada	No sustituye bloqueo de rama medial para seleccionar radiofrecuencia
Radiofrecuencia genicular	70-80 °C, 90-180 s por diana tras bloqueo positivo	Artrosis refractaria y no candidata/no desea cirugía

Anestésico local Dosis total (mg) = concentración (mg/mL) × volumen (mL), sumando todas las dianas. Lidocaína sin adrenalina: máximo habitual de ficha 4,5 mg/kg y generalmente ≤300 mg; bupivacaína sin adrenalina hasta 175 mg por dosis en ficha, aunque en dolor se usa mucho menos. La dosis máxima no es la dosis objetivo: reducir en fragilidad y territorios vasculares y disponer de rescate para toxicidad sistémica por anestésicos locales.

Glosario de siglas

Sigla	Significado
TFESI	infiltración epidural transforaminal
MBB	bloqueo de rama medial
PRP	plasma rico en plaquetas
SASD	bursa subacromial-subdeltoidea
SASDB	bursa subacromial-subdeltoidea
GTPS	síndrome de dolor trocantérico mayor
SCS	estimulación de la médula espinal
DRG	ganglio de la raíz dorsal
PRF	radiofrecuencia pulsada
RF	radiofrecuencia
AL	anestésico local
IA	intraarticular
GH	glenohumeral
LCA	ligamento cruzado anterior
EHL	extensor largo del dedo gordo

Sigla	Significado
SLR	elevación de la pierna recta o Lasègue
ULTT	prueba de tensión neural del miembro superior
ROM	rango de movimiento
RM	resonancia magnética
Rx	radiografía
AINE	antiinflamatorio no esteroideo
NRS	escala numérica del dolor
PEG	escala Pain, Enjoyment and General activity
ODI	índice de discapacidad de Oswestry
KOOS	Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score
WOMAC	Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
LAST	toxicidad sistémica por anestésicos locales
SDRC	síndrome de dolor regional complejo
FA	fibrilación auricular
OSA	apnea obstructiva del sueño
ERC	enfermedad renal crónica
EIPS	espina iliaca posterosuperior
SI	articulación sacroilíaca
RI	rotación interna
FADIR	flexión, aducción y rotación interna de cadera
FABER	flexión, abducción y rotación externa de cadera
MSCC	compresión medular metastásica
ACR	American College of Radiology
ITB	índice tobillo-brazo
EMG	electromiografía
EII	enfermedad inflamatoria intestinal
PCR	proteína C reactiva
TCA	antidepresivo tricíclico
CRPS	síndrome de dolor regional complejo
TC	tomografía computarizada
QT	intervalo QT
AAOS	American Academy of Orthopaedic Surgeons

Sigla	Significado
AAN	American Academy of Neurology
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
IASP	International Association for the Study of Pain
ASRA	American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine
AAPM	American Academy of Pain Medicine
ASIPP	American Society of Interventional Pain Physicians
IPSI	International Pain and Spine Intervention Society

Mapa de casos

Caso 1. Lumbalgia facetaria probable.....	8
Caso 2. Radiculopatía L5 frente a S1.....	12
Caso 3. Estenosis lumbar con claudicación neurógena.....	16
Caso 4. Capsulitis adhesiva frente a supraespinoso.....	20
Caso 5. Tendinopatía del supraespinoso.....	24
Caso 6. Coxartrosis frente a síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS).....	28
Caso 7. Gonartrosis frente a menisco degenerativo.....	32
Caso 8. Lesión ligamentaria de rodilla.....	36
Caso 9. Dolor neuropático periférico que no es sciática.....	40
Caso 10. Gonartrosis en paciente anticoagulado.....	44
Caso 11. Radiculopatía L4 frente a neuropatía femoral y coxopatía.....	48
Caso 12. Dolor discogénico probable frente a faceta y sacroilíaca.....	53
Caso 13. Claudicación vascular que imita estenosis lumbar.....	57
Caso 14. Sospecha de cola de caballo: la consulta que se interrumpe.....	61
Caso 15. Dolor sacroilíaco frente a cadera y faceta lumbar.....	65
Caso 16. Radiculopatía cervical C6 frente a hombro doloroso.....	69
Caso 17. Rotura significativa del manguito frente a tendinopatía.....	73
Caso 18. Coxalgia intraarticular frente a dolor lumbar referido.....	77
Caso 19. Dolor patelofemoral frente a menisco y tendón rotuliano.....	81
Caso 20. Rodilla caliente: sepsis frente a cristales y brote artrósico.....	85
Caso 21. Neuralgia postherpética frente a radiculopatía.....	89
Caso 22. Síndrome de dolor regional complejo tras fractura.....	93
Caso 23. Dolor nociplástico generalizado: cuándo dejar de buscar dianas.....	97
Caso 24. Dolor vertebral en paciente oncológico: sospecha de compresión metastásica.....	101
Caso 25. Dolor de cadera o sacroilíaca: decisión con hallazgos coexistentes.....	105
Caso 26. Irradiación lumbar: L5 frente a S1 sin fiarse solo del dermatoma.....	110
Caso 27. Dolor persistente tras cirugía lumbar: reformular antes de otra técnica.....	115
Caso 28. Cervicalgia facetaria y cefalea occipital frente a radiculopatía.....	119

Caso 29. Dolor después de prótesis total de rodilla.....	123
Caso 30. Meralgia parestésica frente a radiculopatía lumbar alta.....	127
Caso 31. Fractura vertebral osteoporótica frente a lumbalgia mecánica.....	131
Caso 32. Dolor neuropático crónico después de mastectomía.....	135
Caso 33. Opioides y polifarmacia depresora en paciente frágil.....	139
Caso 34. Dolor lumbar inflamatorio frente a dolor mecánico.....	143

Caso 1. Lumbalgia facetaria probable

Presentación Varón de 61 años, dolor lumbar derecho de 2 años, sin dolor distal ni déficit. Quiere volver a caminar una hora.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿El dolor baja de la rodilla o hay hormigueo?	Paciente: No	Experto: Reduce raíz dominante; permite explorar patrón axial.
Médico: ¿Peor de pie, extensión y giro?	Paciente: Sí; mejora sentado	Experto: Sube faceta, pero no la confirma.
Médico: ¿Qué quiere recuperar?	Paciente: Caminar una hora	Experto: Será la tarea del bloqueo y del seguimiento.

Pensamiento del experto La resonancia magnética (RM) facetaria no decide. Primero necesito síndrome axial, neurología normal, exclusión de cadera/articulación sacroilíaca (SI) y saber si una radiofrecuencia (RF) sería realmente el siguiente paso.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	A: insidioso; L: paravertebral bajo; I: 6/10; C: profundo/mecánico; I: glúteo, no bajo rodilla; A: peor extensión, de pie y giro, mejor sentado.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 61 años, dolor lumbar derecho de 2 años, sin dolor distal ni déficit. Quiere volver a caminar una hora.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	A dominante (facetas L4-L5/L5-S1), B nociceptivo mecánico, C miedo leve, D limita bipedestación, E favorable. Síndrome facetario probable.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Varón de 61 años, dolor lumbar derecho de 2 años, sin dolor distal ni déficit. Quiere volver a caminar una hora.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	A: insidioso; L: paravertebral bajo; I: 6/10; C: profundo/mecánico; I: glúteo, no bajo rodilla; A: peor extensión, de pie y giro, mejor sentado.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	A dominante (facetas L4-L5/L5-S1), B nociceptivo mecánico, C miedo leve, D limita bipedestación, E favorable. Síndrome facetario probable.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Extensión-rotación reproduce dolor habitual; neuro normal; elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) negativo; cadera y articulación sacroilíaca (SI) no reproducen.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	resonancia magnética (RM) con artrosis facetaria se interpreta como concordante, no confirmatoria.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Radiculopatía: poco probable porque no hay dolor distal, déficit ni tensión neural; si aparecieran, el bloqueo de rama medial (MBB) dejaría de ser la siguiente prueba.
- Sacroilíaca: buscar dolor bajo espina ilíaca posteriosuperior (EIPS) y clúster de provocación; aquí no se reproduce.

- Cadera: la rotación interna y flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) no reproducen el dolor; la imagen facetaria aislada no confirma causalidad.

7. Formulación del experto y grado de certeza

A dominante (facetas L4-L5/L5-S1), B nociceptivo mecánico, C miedo leve, D limita bipedestación, E favorable. Síndrome facetario probable.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: A dominante (facetas L4-L5/L5-S1), B nociceptivo mecánico, C miedo leve, D limita bipedestación, E favorable. Síndrome facetario probable.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Programa de fuerza lumbar/cadera y exposición a bipedestación 6 semanas; antiinflamatorio no esteroideo (AINE) corto si seguro.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si persiste y se contempla radiofrecuencia (RF): bloqueo de rama medial (MBB) L3, L4 y ramo dorsal L5 derecho, 0,3-0,5 mL anestésico local (AL) por diana.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si alivio concordante y funcional según umbral local: radiofrecuencia (RF) térmica 80-90 °C, 60-120 s/lesión con técnica validada.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Diario tras bloqueo de rama medial (MBB); revisión 2 semanas. Tras radiofrecuencia (RF): 2 y 6-8 semanas. Éxito: caminar 45-60 min y reducir rescates.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El bloqueo de rama medial (MBB) baja escala numérica del dolor (NRS) un 70%, pero no mejora ninguna actividad provocadora.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Un porcentaje sin conducta funcional concordante es una respuesta dudosa; no programe radiofrecuencia (RF) por el número aislado.

Error frecuente Indicar radiofrecuencia (RF) por artrosis facetaria en resonancia magnética (RM) sin bloqueo pronóstico concordante.

Caso 2. Radiculopatía L5 frente a S1

Presentación Mujer de 44 años con dolor de pierna derecha mayor que lumbar tras levantar peso, de 5 semanas.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Dónde termina exactamente?	Paciente: Primer espacio interdigital	Experto: Favorece L5, pero todavía necesito fuerza.
Médico: ¿Talones o puntillas?	Paciente: Falla talón; puntilla normal	Experto: L5 gana frente a S1.
Médico: ¿Tos o elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) reproducen?	Paciente: Sí	Experto: Apoya raíz frente a dolor referido.

Pensamiento del experto No voy a localizar la raíz por un dibujo. Busco convergencia: extensor largo del dedo gordo (EHL)/dorsiflexión, abducción de cadera, reflejos, tensión y resonancia magnética (RM) de receso/foramen.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Trayecto lateral de pierna al dorso del pie y primer espacio; descargas; peor sentada y con tos.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 44 años con dolor de pierna derecha mayor que lumbar tras levantar peso, de 5 semanas.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Radiculopatía L5 derecha probable por lesión L4-L5, sin déficit progresivo grave.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Mujer de 44 años con dolor de pierna derecha mayor que lumbar tras levantar peso, de 5 semanas.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Trayecto lateral de pierna al dorso del pie y primer espacio; descargas; peor sentada y con tos.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Radiculopatía L5 derecha probable por lesión L4-L5, sin déficit progresivo grave.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) reproduce a 40°; hipoestesia primer espacio; extensor largo del dedo gordo (EHL) 4+/5; talones difíciles; reflejos conservados.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Si fuera S1 esperaríamos borde lateral/planta, flexión plantar/puntillas y aquileo reducido.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- S1: esperar borde lateral/planta, debilidad en flexión plantar y aquileo reducido; el patrón del primer espacio y extensor largo del dedo gordo (EHL) favorece L5.

- Neuropatía peronea común: dorsiflexión/eversión débiles, sensibilidad dorsal y posible Tinel en cabeza peronea, pero no dolor con elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) ni abducción de cadera débil.
- Cadera/síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS): no explican tos positiva, trayecto hasta primer espacio ni déficit miotómico.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Radiculopatía L5 derecha probable por lesión L4-L5, sin déficit progresivo grave.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Radiculopatía L5 derecha probable por lesión L4-L5, sin déficit progresivo grave.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Actividad graduada, información y vigilancia motora. Evitar gabapentinoide rutinario para sciática [4].

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

En sciática no usar gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoide oral ni opioide crónico de rutina. Si se usa analgesia simple o antiinflamatorio no esteroideo, que sea un ensayo corto, con cribado renal/gastrointestinal/cardiovascular y objetivo funcional.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si dolor agudo grave persiste y resonancia magnética (RM) concuerda: infiltración epidural transforaminal (TFESI) L5 con contraste, lidocaína 1% 1 mL y dexametasona 4-10 mg, total ≤ 4 mL.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- resonancia magnética (RM) por déficit y posible escalada.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisar fuerza en 1-2 semanas; urgente si progresa. Éxito: dormir y sentarse 60 min; cirugía si déficit/problema estructural refractario.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso En la revisión aparece debilidad progresiva del extensor largo del dedo gordo (EHL) y tibial anterior.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La aparición de déficit cambia el circuito; no se resuelve repitiendo una epidural electiva.

Error frecuente Nombrar el nivel solo por el dibujo del dolor y no repetir fuerza/reflejos en seguimiento.

Caso 3. Estenosis lumbar con claudicación neurógena

Presentación Varón de 74 años: pesadez bilateral tras 120 m; mejora al sentarse y camina más con carrito.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Al parar basta quedarse de pie?	Paciente: No; debo sentarme	Experto: Favorece claudicación neurógena.
Médico: ¿Carrito o bicicleta?	Paciente: Los tolero mejor	Experto: Apoya dependencia de flexión.
Médico: ¿Distancia reproducible?	Paciente: A unos 120 metros	Experto: Proporciona métrica basal.

Pensamiento del experto Una resonancia magnética (RM) con estenosis no basta. Necesito el síndrome de marcha, diferenciar vascular y cadera y medir función antes de discutir epidural o cirugía.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Inicio progresivo; síntomas por encima y debajo de rodillas; no quemazón fija; no esfínteres.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 74 años: pesadez bilateral tras 120 m; mejora al sentarse y camina más con carrito.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Estenosis central multinivel con claudicación neurógena; discapacidad alta. Diferencial vascular evaluado.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Varón de 74 años: pesadez bilateral tras 120 m; mejora al sentarse y camina más con carrito.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Inicio progresivo; síntomas por encima y debajo de rodillas; no quemazón fija; no esfínteres.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Estenosis central multinivel con claudicación neurógena; discapacidad alta. Diferencial vascular evaluado.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Neuro casi normal en reposo; extensión reproduce; pulsos presentes; prueba de marcha 130 m; cadera no limita.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Claudicación vascular: suele aliviar al detenerse incluso de pie; buscar pulsos, piel, factores vasculares e índice tobillo-brazo (ITB). La flexión y el carrito favorecen estenosis.
- Coxartrosis: dolor inguinal, rotación interna (RI) limitada y dificultad de calzado; no explica bien pesadez bilateral dependiente de postura lumbar.
- Neuropatía periférica: síntomas distales más constantes y menos ligados a distancia de marcha.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Estenosis central multinivel con claudicación neurógena; discapacidad alta. Diferencial vascular evaluado.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Estenosis central multinivel con claudicación neurógena; discapacidad alta. Diferencial vascular evaluado.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Ejercicio adaptado en flexión, bicicleta, fuerza, ayuda de marcha y optimización comorbilidades.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No ofrecer epidural como rutina [4]. Solo excepción consensuada tras explicar evidencia limitada; si se usa caudal: dexametasona 4-10 mg + suero, 10-20 mL titulado, anestésico local (AL) bajo o ninguno.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- resonancia magnética (RM) si no disponible y valoración de descompresión si impacto persiste.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Medir distancia de marcha y paradas a 4-6 semanas. Derivación quirúrgica si deterioro o fracaso funcional.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diaria + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diátesis, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso A seis semanas camina 400 m aunque el escala numérica del dolor (NRS) solo baja de 7 a 6.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La mejoría funcional es éxito clínico; no escale por perseguir una cifra de dolor.

Error frecuente Pautar una dosis seriada sin medir distancia de marcha ni discutir descompresión.

Caso 4. Capsulitis adhesiva frente a supraespinoso

Presentación Mujer de 56 años con diabetes, 4 meses de dolor nocturno y dificultad para peinarse y abrocharse.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Primero dolor y luego rigidez?	Paciente: Sí	Experto: Patrón típico de capsulitis.
Médico: ¿Puede peinarse y alcanzar la espalda?	Paciente: No	Experto: Define tareas funcionales.
Médico: ¿Diabetes o tiroides?	Paciente: Diabetes tipo 2	Experto: Modifica riesgo y vigilancia.

Pensamiento del experto La primera bifurcación es activa frente a pasiva. Si ambas están limitadas, especialmente rotación externa, manguito aislado baja de probabilidad.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Inicio progresivo sin trauma; dolor seguido de rigidez; no parestesias.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 56 años con diabetes, 4 meses de dolor nocturno y dificultad para peinarse y abrocharse.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Capsulitis adhesiva, fase dolorosa-rígida. En tendinopatía supra la pasiva estaría casi conservada y Jobe/arco doloroso dominarían.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Mujer de 56 años con diabetes, 4 meses de dolor nocturno y dificultad para peinarse y abrocharse.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Inicio progresivo sin trauma; dolor seguido de rigidez; no parestesias.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Capsulitis adhesiva, fase dolorosa-rígida. En tendinopatía supra la pasiva estaría casi conservada y Jobe/arco doloroso dominarían.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Activa y pasiva limitadas; rotación externa pasiva 20° frente a 65° contralateral; sin lag verdadero.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	radiografía (Rx) sin artrosis avanzada; eco sin rotura completa.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Tendinopatía del manguito: movilidad pasiva casi conservada; aquí la rotación externa pasiva está claramente restringida.
- Artrosis glenohumeral: también limita activa y pasiva, pero la radiografía mostraría cambios concordantes.
- Rotura grande: lag/debilidad verdadera con pasiva preservada; no es el patrón.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Capsulitis adhesiva, fase dolorosa-rígida. En tendinopatía supra la pasiva estaría casi conservada y Jobe/arco doloroso dominarían.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Capsulitis adhesiva, fase dolorosa-rígida. En tendinopatía supra la pasiva estaría casi conservada y Jobe/arco doloroso dominarían.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, control glucémico y movilidad dosificada.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Glenohumeral ecoguiada: triamcinolona 20 mg + lidocaína 1% 2-4 mL; considerar hidrodilatación 15-25 mL si rigidez dominante y protocolo.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Rehabilitación precoz coordinada.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo

institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2 semanas (dolor/glucemia) y 6 semanas (rotación externa, mano-espalda, sueño).

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diaria + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Tras glenohumeral (GH) duerme mejor, pero la rotación externa no mejora porque no inició movilidad.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La infiltración debe abrir una ventana para rehabilitar; analgesia sin recuperación de rango de movimiento (ROM) no completa el plan.

Error frecuente Explorar solo movimiento activo y etiquetar cualquier hombro rígido como manguito.

Caso 5. Tendinopatía del supraespinoso

Presentación Varón de 48 años, pintor, dolor lateral con trabajo sobre cabeza; pasiva conservada.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Trauma con pérdida súbita de fuerza?	Paciente: No	Experto: Reduce rotura aguda reparable.
Médico: ¿Dolor lateral con arco y trabajo elevado?	Paciente: Sí	Experto: Apoya manguito/bursa subacromial-subdeltoidea (SASD).
Médico: ¿Parestesias o dolor cervical?	Paciente: No	Experto: Reduce imitador cervical.

Pensamiento del experto Diferencio dolor de debilidad verdadera. Pasiva conservada y fuerza razonable favorecen tendinopatía; no necesito resonancia magnética (RM) rutinaria si la eco responde la pregunta.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Sobrecarga; arco doloroso; sueño sobre ese lado; no rigidez progresiva global.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 48 años, pintor, dolor lateral con trabajo sobre cabeza; pasiva conservada.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Síndrome subacromial/tendinopatía del supraespinoso, sin capsulitis.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Varón de 48 años, pintor, dolor lateral con trabajo sobre cabeza; pasiva conservada.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Sobrecarga; arco doloroso; sueño sobre ese lado; no rigidez progresiva global.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Síndrome subacromial/tendinopatía del supraespinoso, sin capsulitis.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Arco 70-120°, Jobe doloroso con fuerza conservada, Hawkins positivo; rotación externa pasiva completa; eco con tendinopatía sin rotura grande.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Capsulitis: descartada por rotación externa pasiva completa.
- Rotura completa: menos probable con fuerza conservada y sin lag; una eco bien realizada apoya tendinopatía.
- Radiculopatía cervical: buscar dolor cervical, parestesias, reflejos y Spurling; no debe omitirse si el dolor rebasa el codo.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Síndrome subacromial/tendinopatía del supraespinoso, sin capsulitis.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE

+ alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Síndrome subacromial/tendinopatía del supraespinoso, sin capsulitis.»
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Modificar carga temporal y programa de fuerza manguito/escápula.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

bursa subacromial-subdeltoidea (SASD) solo si dolor impide rehabilitación: triamcinolona 20 mg + lidocaína 1% 2-4 mL, total 3-5 mL, estrictamente intrabursal.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- No corticoide intratendinoso ni repeticiones automáticas.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

4-6 semanas: trabajo sobre cabeza, dolor nocturno y fuerza. Derivar si aparece lag o debilidad progresiva.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El primer corticoide alivió diez días y solicita repetirlo sin haber progresado carga.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda No repita una ventana que no se utilizó. Reoriente expectativas y reconstruya el programa de carga.

Error frecuente Repetir corticoide porque el primero fue brevemente analgésico sin progresar carga.

Caso 6. Coxartrosis frente a síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS)

Presentación Mujer de 67 años con dolor lateral de cadera al dormir y subir escaleras; puede ponerse calcetines.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Ingle o lateral?	Paciente: Lateral sobre trocánter	Experto: síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS) gana frente a cadera intraarticular (IA).
Médico: ¿Calcetines/coche/giro?	Paciente: Casi normal	Experto: Coxartrosis sintomática baja.
Médico: ¿Dormir sobre ese lado?	Paciente: Imposible	Experto: Tarea diana útil.

Pensamiento del experto Exploro rotación interna/log-roll antes de etiquetar trocánter. Después combino palpación y abducción resistida; una sola prueba es insuficiente.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Dolor lateral, no inguinal; peor decúbito y apoyo monopodal.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 67 años con dolor lateral de cadera al dormir y subir escaleras; puede ponerse calcetines.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS)/tendinopatía glútea. Coxartrosis sería más inguinal, con dificultad de calzado y rotación interna (RI) limitada.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Mujer de 67 años con dolor lateral de cadera al dormir y subir escaleras; puede ponerse calcetines.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Dolor lateral, no inguinal; peor decúbiteo y apoyo monopodal.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS)/tendinopatía glútea. Coxartrosis sería más inguinal, con dificultad de calzado y rotación interna (RI) limitada.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	rotación interna (RI) pasiva casi normal; log-roll y flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) no reproducen; palpación glútea y abducción resistida positivas; apoyo 30 s reproduce.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Coxartrosis: menos probable por ausencia de ingule, función de calzado conservada y rotación interna (RI) casi normal.
- Radiculopatía L5: no hay trayecto distal, parestesias, déficit ni tensión neural.
- Rotura glútea: sospechar si Trendelenburg/debilidad marcada o fracaso del programa; requeriría imagen tendinosa.

7. Formulación del experto y grado de certeza

síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS)/tendinopatía glútea. Coxartrosis sería más inguinal, con dificultad de calzado y rotación interna (RI) limitada.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS)/tendinopatía glútea. Coxartrosis sería más inguinal, con dificultad de calzado y rotación interna (RI) limitada.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación para reducir compresión y carga progresiva abductora.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si dolor bloquea ejercicio: peritrocantérica ecoguiada con triamcinolona 20-40 mg + 2-4 mL lidocaína 1%, evitando tendón.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- plasma rico en plaquetas (PRP) solo bajo gobernanza y tras explicar incertidumbre.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo

institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

6 y 12 semanas: decúbito, escaleras, apoyo monopodal. Si debilidad marcada, imagen de tendones.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Tras dos infiltraciones presenta Trendelenburg y debilidad progresiva.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La debilidad cambia la pregunta hacia tendón glúteo/rotura; repetir corticoide puede retrasar el diagnóstico y la carga correcta.

Error frecuente Infiltrar el trocánter sin probar rotación interna (RI) de cadera ni explorar columna.

Caso 7. Gonartrosis frente a menisco degenerativo

Presentación Varón de 68 años con dolor medial progresivo, rigidez 10 min, crepitación y un informe de resonancia magnética (RM) que dice «rotura meniscal».

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Hubo giro agudo y bloqueo verdadero?	Paciente: No	Experto: Resta menisco traumático reparable.
Médico: ¿Rigidez breve y dolor con carga?	Paciente: Sí	Experto: Favorece artrosis.
Médico: ¿Rodilla caliente o fiebre?	Paciente: No	Experto: Permite circuito ordinario.

Pensamiento del experto Una rotura degenerativa en resonancia magnética (RM) puede ser incidental. El fenotipo clínico y la radiografía en carga pesan más para decidir tratamiento.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Sin giro traumático, hemartros ni bloqueo verdadero; carga y escaleras.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 68 años con dolor medial progresivo, rigidez 10 min, crepitación y un informe de resonancia magnética (RM) que dice «rotura meniscal».
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Gonartrosis sintomática con hallazgo meniscal degenerativo posiblemente incidental.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Varón de 68 años con dolor medial progresivo, rigidez 10 min, crepitación y un informe de resonancia magnética (RM) que dice «rotura meniscal».
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Sin giro traumático, hemartros ni bloqueo verdadero; carga y escaleras.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Gonartrosis sintomática con hallazgo meniscal degenerativo posiblemente incidental.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Eje varo, rango de movimiento (ROM) doloroso final, crepitación, interlínea sensible; McMurray molesto sin click/bloqueo; radiografía (Rx) en carga con artrosis medial.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Menisco traumático reparable: faltan giro agudo, derrame tardío y bloqueo verdadero.
- Dolor patelofemoral: sería anterior y dominarían sentadilla, escaleras y sedestación, no artrosis medial en carga.
- Artritis inflamatoria/séptica: no hay calor, gran derrame, rigidez prolongada ni síntomas sistémicos.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Gonartrosis sintomática con hallazgo meniscal degenerativo posiblemente incidental.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Gonartrosis sintomática con hallazgo meniscal degenerativo posiblemente incidental.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Fuerza, aeróbico, peso y antiinflamatorio no esteroideo (AINE) tópico; discutir artroplastía si impacto grave.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Brote: intraarticular (IA) triamcinolona 40 mg máximo inicial + 2-4 mL lidocaína 1%. Si refractario y no candidato/no desea cirugía: bloqueo genicular; radiofrecuencia (RF) 70-80 °C, 90-180 s si positivo y gobernanza [16,20].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

6 semanas: Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)/Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) o función elegida, marcha y escaleras; tras intraarticular (IA) 2-6 semanas.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diaria + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El informe de resonancia magnética (RM) dice 'rotura meniscal compleja' y el paciente exige artroscopia.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Explique la discordancia imagen-síntoma. Trate artrosis y función, no una palabra del informe.

Error frecuente Tratar el informe de resonancia magnética (RM) en vez del fenotipo clínico dominante.

Caso 8. Lesión ligamentaria de rodilla

Presentación Mujer de 29 años con giro jugando fútbol, chasquido, derrame en 2 horas y sensación de fallo.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Pivot, chasquido y hemartros precoz?	Paciente: Sí	Experto: ligamento cruzado anterior (LCA) sube con fuerza.
Médico: ¿Giving-way?	Paciente: Sí	Experto: Confirma impacto funcional.
Médico: ¿Dolor óseo o pulsos alterados?	Paciente: No	Experto: Reduce fractura/vascular, sin excluir asociadas.

Pensamiento del experto Tras trauma no empiezo por una infiltración. Estabilidad, derrame, neurovascular y lesiones asociadas determinan la derivación.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Trauma pivotante; incapacidad de continuar; no cuadro degenerativo previo.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 29 años con giro jugando fútbol, chasquido, derrame en 2 horas y sensación de fallo.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Lesión ligamento cruzado anterior (LCA) hasta demostrar lo contrario; posible lesión meniscal asociada.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Mujer de 29 años con giro jugando fútbol, chasquido, derrame en 2 horas y sensación de fallo.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Trauma pivotante; incapacidad de continuar; no cuadro degenerativo previo.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Lesión ligamento cruzado anterior (LCA) hasta demostrar lo contrario; posible lesión meniscal asociada.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Derrame; Lachman con tope blando; pivot shift diferido por dolor; valgo/varo estables; neurovascular normal.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Menisco aislado: puede causar giro y derrame, pero hemartros precoz, giving-way y Lachman anormal favorecen ligamento cruzado anterior (LCA).
- Luxación rotuliana reducida: preguntar deformidad lateral y aprehensión; puede producir hemartros.
- Fractura osteocondral/tibial: dolor óseo focal o reglas de Ottawa positivas obligan a radiografía.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Lesión ligamento cruzado anterior (LCA) hasta demostrar lo contrario; posible lesión meniscal asociada.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE

+ alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Lesión ligamento cruzado anterior (LCA) hasta demostrar lo contrario; posible lesión meniscal asociada.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Protección, control derrame, recuperar extensión y activación cuádriceps.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No infiltrar corticoide ni plasma rico en plaquetas (PRP) como sustituto de diagnóstico y estabilización.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- resonancia magnética (RM) y traumatología según objetivos/inestabilidad.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejó escrito

Revisión precoz 1-2 semanas y plan compartido de rehabilitación/reconstrucción.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El residente propone plasma rico en plaquetas (PRP) para ganar tiempo antes de traumatología.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Una sustancia no sustituye diagnóstico de inestabilidad ni reconstruye un ligamento roto.

Error frecuente Usar plasma rico en plaquetas (PRP)/corticoide para retrasar la evaluación de inestabilidad traumática.

Caso 9. Dolor neuropático periférico que no es sciática

Presentación Mujer de 63 años con diabetes: quemazón y descargas simétricas en ambos pies, peor por la noche; no dolor lumbar ni trayecto radicular.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Simétrico en calcetín?	Paciente: Sí	Experto: Favorece polineuropatía.
Médico: ¿Dolor lumbar y elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR)?	Paciente: No	Experto: Sciática baja.
Médico: ¿Alodinia, pérdida vibratoria y equilibrio?	Paciente: Sí	Experto: Fenotipo neuropático y riesgo de caída.

Pensamiento del experto Antes de gabapentinoide demuestro lesión somatosensorial plausible, reviso riñón, sueño, caídas y objetivo funcional.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	A: progresivo; L: patrón en calcetín bilateral; I: 7/10 nocturno; C: quemazón/alodinia; I: distal simétrica; A: roce de sábanas y noche.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 63 años con diabetes: quemazón y descargas simétricas en ambos pies, peor por la noche; no dolor lumbar ni trayecto radicular.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Polineuropatía dolorosa distal probable, no radiculopatía. B neuropático dominante; D sueño; revisar control metabólico y otras causas.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Mujer de 63 años con diabetes: quemazón y descargas simétricas en ambos pies, peor por la noche; no dolor lumbar ni trayecto radicular.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	A: progresivo; L: patrón en calcetín bilateral; I: 7/10 nocturno; C: quemazón/alodinia; I: distal simétrica; A: roce de sábanas y noche.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Polineuropatía dolorosa distal probable, no radiculopatía. B neuropático dominante; D sueño; revisar control metabólico y otras causas.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Alodinia y pérdida de vibración distal; aquíleos reducidos simétricos; fuerza proximal conservada; elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) negativo.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Inspección de pies, pulsos y riesgo de úlcera; analítica/estudio etiológico según contexto.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Radiculopatía: suele ser asimétrica y dermatomal con dolor lumbar/tensión neural; aquí es distal simétrica en calcetín.
- Enfermedad vascular: pulsos, piel, úlceras e índice tobillo-brazo (ITB); no explica por sí sola alodinia y pérdida vibratoria simétrica.

- Eritromelalgia o atrapamiento focal: distribución y desencadenantes serían distintos.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Polineuropatía dolorosa distal probable, no radiculopatía. B neuropático dominante; D sueño; revisar control metabólico y otras causas.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Polineuropatía dolorosa distal probable, no radiculopatía. B neuropático dominante; D sueño; revisar control metabólico y otras causas.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, cuidado de pies, ejercicio y optimización etiológica.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Elegir un solo ensayo según comorbilidad: duloxetine 30 mg/día 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; o amitriptilina 10 mg por la noche, habitualmente 10-50 mg, si el riesgo anticolinérgico/intervalo QT (QT)/caídas es bajo. Gabapentina 100-300 mg nocturnos con titulación y ajuste renal, o pregabalina 25-75 mg nocturnos/75 mg cada 12 h con ajuste renal, solo cuando estén indicadas. Revisar tolerancia a 2 semanas y eficacia funcional a 4-8; retirar gradualmente si fracasa. Lidocaína tópica 5%: hasta 12 h/día en piel íntegra y zona localizada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Elegir un solo ensayo: p. ej., duloxetine 30 mg/d y subir a 60 mg/d si tolera, o alternativa según comorbilidad [25].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Definir retirada si a 4-8 semanas no mejora sueño o función; no extrapolar la prohibición de gabapentinoides en sciática a toda neuropatía.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2 semanas por tolerancia y 6 por eficacia; registrar sueño, marcha, alodinia, caídas y efectos adversos.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Pregabalina reduce dolor 2 puntos pero causa somnolencia y dos caídas.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Beneficio analgésico sin seguridad ni función no es éxito; reduzca/retire de forma gradual y replantee.

Error frecuente Mantener gabapentinoide sedante sin objetivo funcional ni ajuste renal.

Caso 10. Gonartrosis en paciente anticoagulado

Presentación Varón de 78 años con gonartrosis y fibrilación auricular anticoagulada; solicita infiltración por brote que impide iniciar ejercicio.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Por qué está anticoagulado?	Paciente: fibrilación auricular (FA) con ictus previo	Experto: Alto coste trombótico de suspender.
Médico: ¿Calor, derrame brusco o fiebre?	Paciente: No	Experto: Reduce hemartros/sepsis.
Médico: ¿Qué actividad limita?	Paciente: Escaleras	Experto: Métrica funcional.

Pensamiento del experto No suspendo anticoagulación por reflejo. Clasifico riesgo del procedimiento, compresibilidad, función renal y coordinación con prescriptor.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Dolor mecánico sin fiebre, trauma ni bloqueo; conocer fármaco, dosis, última toma, función renal, sangrados y riesgo trombótico.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 78 años con gonartrosis y fibrilación auricular anticoagulada; solicita infiltración por brote que impide iniciar ejercicio.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Gonartrosis sintomática; procedimiento articular periférico superficial de bajo riesgo, sin factores hemorrágicos añadidos identificados.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Varón de 78 años con gonartrosis y fibrilación auricular anticoagulada; solicita infiltración por brote que impide iniciar ejercicio.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Dolor mecánico sin fiebre, trauma ni bloqueo; conocer fármaco, dosis, última toma, función renal, sangrados y riesgo trombótico.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Gonartrosis sintomática; procedimiento articular periférico superficial de bajo riesgo, sin factores hemorrágicos añadidos identificados.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Rodilla no caliente, derrame pequeño, crepitación y rango de movimiento (ROM) doloroso; sin equimosis extensa. Si estuviera caliente, aspirar/estudiar antes de corticoide.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Hemartros: aumento brusco de volumen, equimosis y dolor desproporcionado cambiarían el plan hacia aspiración/estudio.
- Artritis séptica o por cristales: una rodilla caliente exige líquido sinovial antes de corticoide.
- Trombosis venosa: edema de pierna, dolor de pantorrilla o disnea no deben atribuirse a artrosis.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Gonartrosis sintomática; procedimiento articular periférico superficial de bajo riesgo, sin factores hemorrágicos añadidos identificados.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Gonartrosis sintomática; procedimiento articular periférico superficial de bajo riesgo, sin factores hemorrágicos añadidos identificados.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

No ordenar suspensión por rutina. Confirmar guía local y coordinar si el riesgo es incierto [1,32].

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si se procede: ecografía, aguja fina, compresión; triamcinolona 40 mg máximo inicial + lidocaína 1% 2-4 mL, calculando mg totales.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Usar la ventana analgésica para fuerza y marcha; instrucciones de hemartros, infección y toxicidad sistémica por anestésicos locales (LAST).

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Contacto si aumenta derrame/equimosis; revisión a 2-6 semanas con función y eventos. No repetir si no hubo ganancia funcional.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El día previsto la rodilla está caliente y aparece gran derrame.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La nueva información invalida la infiltración terapéutica: artrocentesis diagnóstica primero.

Error frecuente Suspender anticoagulación sin valorar trombosis o infiltrar una rodilla caliente.

Caso 11. Radiculopatía L4 frente a neuropatía femoral y coxopatía

Presentación Varón de 58 años con dolor anterior de muslo y cara medial de pierna tras un episodio lumbar. Refiere que la rodilla «falla» al bajar escaleras.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿El dolor comienza en espalda/inglete o distalmente? ¿Empeora con tos? ¿Hubo cirugía pélvica, hematoma, anticoagulación o posición prolongada?	Paciente: Empieza en la espalda y baja por la cara anterior del muslo hacia la rodilla y la pierna medial.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿La dificultad es extender rodilla, flexionar cadera, aducirla o simplemente dolor? ¿Puede ponerse calcetines?	Paciente: Me cuesta extender la rodilla, pero puedo mover el tobillo.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Hay hipoestesia en muslo anterior, rodilla o tibia medial? ¿Dolor inguinal con giro?	Paciente: Noto menos la parte medial de la pierna; girar la cadera no reproduce dolor inguinal.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Radiculopatía L4 probable con déficit motor leve. La decisión no es infiltrar inmediatamente, sino documentar fuerza, solicitar resonancia magnética (RM) concordante por déficit y vigilar progresión. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Confundir L4 con cadera por dolor anterior o con femoral sin explorar tibial anterior, aductores y provocación lumbar.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿El dolor comienza en espalda/ingle o distalmente? ¿Empeora con tos? ¿Hubo cirugía pélvica, hematoma, anticoagulación o posición prolongada?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 58 años con dolor anterior de muslo y cara medial de pierna tras un episodio lumbar. Refiere que la rodilla «falla» al bajar escaleras.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Radiculopatía L4 probable con déficit motor leve. La decisión no es infiltrar inmediatamente, sino documentar fuerza, solicitar resonancia magnética (RM) concordante por déficit y vigilar progresión.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿La dificultad es extender rodilla, flexionar cadera, aducirla o simplemente dolor? ¿Puede ponerse calcetines?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Hay hipoestesia en muslo anterior, rodilla o tibia medial? ¿Dolor inguinal con giro?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Radiculopatía L4 probable con déficit motor leve. La decisión no es infiltrar inmediatamente, sino documentar fuerza, solicitar resonancia magnética (RM) concordante por déficit y vigilar progresión.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Dolor lumbar que cruza muslo anterior hasta tibia medial; tos positiva. Femoral stretch reproduce el trayecto.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 2	Cuádriceps 4/5, tibial anterior 4+/5, reflejo rotuliano reducido; aducción de cadera ligeramente débil. Sensibilidad medial de pierna reducida.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Rotación interna de cadera conservada y flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) no reproduce ingre; no antecedente pélvico ni masa inguinal.	Comprueba concordancia con la actividad diaria y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Raíz L4 por lesión L3-L4: integra dolor lumbar, tos, femoral stretch, cuádriceps/tibial anterior, aducción y rotuliano.
- Neuropatía femoral: explicaría cuádriceps y reflejo, pero no tibial anterior/aductores ni provocación lumbar; buscar hematoma retroperitoneal si anticoagulado.
- Coxartrosis: puede referir a rodilla, pero esperaríamos ingre, rotación interna (RI) limitada y dificultad de calzado, ausentes aquí.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Radiculopatía L4 probable con déficit motor leve. La decisión no es infiltrar inmediatamente, sino documentar fuerza, solicitar resonancia magnética (RM) concordante por déficit y vigilar progresión.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Radiculopatía L4 probable con déficit motor leve. La decisión no es infiltrar inmediatamente, sino documentar fuerza, solicitar resonancia magnética (RM) concordante por déficit y vigilar progresión.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Actividad graduada, analgesia no opioide según riesgo y educación sobre alarma motora/esfínteres.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

En sciática no usar gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoide oral ni opioide crónico de rutina. Si se usa analgesia simple o antiinflamatorio no esteroideo, que sea un ensayo corto, con cribado renal/gastrointestinal/cardiovascular y objetivo funcional.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

resonancia magnética (RM) lumbar. Si dolor agudo grave persiste sin progresión y la resonancia magnética (RM) confirma diana: infiltración epidural transforaminal (TFESI) L4 con contraste, lidocaína 1% 1 mL de prueba y dexametasona 4-10 mg; volumen total ≤ 4 mL [7,17]. Déficit progresivo o cuádriceps claramente $<4/5$: valoración espinal precoz; la epidural no sustituye descompresión cuando hay deterioro.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisar fuerza, reflejo, caídas y marcha en 7-14 días. Objetivo: bajar un tramo de escaleras con seguridad y recuperar extensión; si no mejora a 4-6 semanas, revalorar diagnóstico/cirugía.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso En la revisión progresa la debilidad del cuádriceps.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La progresión motora obliga a imagen/valoración prioritaria; no se trata repitiendo una técnica electiva.

Error frecuente Confundir L4 con cadera por dolor anterior o con femoral sin explorar tibial anterior, aductores

y provocación lumbar.

Caso 12. Dolor discogénico probable frente a faceta y sacroilíaca

Presentación Mujer de 39 años con dolor lumbar central de nueve meses, peor sentada y al inclinarse, sin dolor de pierna ni déficit.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Aumenta al sentarse, flexionar, levantar carga o toser? ¿Hay dolor al extender/girar o bajo una espina ilíaca posterosuperior (EIPS)?	Paciente: Me empeora estar sentado e inclinarme; levantarme y caminar suave me alivia.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Se centraliza o peripheraliza con movimientos repetidos? ¿Sueño, miedo, trabajo y pausas?	Paciente: No baja claramente al pie ni tengo debilidad.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Fiebre, cáncer, trauma, rigidez inflamatoria o dolor nocturno no mecánico?	Paciente: La extensión me molesta menos que la flexión mantenida.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Lumbalgia axial mecánica probablemente discogénica, sin indicación de bloqueo de rama medial (MBB), epidural ni discografía rutinaria. El objetivo es restaurar tolerancia a carga y sedestación. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Convertir una protrusión o deshidratación en diagnóstico causal y ofrecer una epidural para dolor exclusivamente axial.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A - Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Aumenta al sentarse, flexionar, levantar carga o toser? ¿Hay dolor al extender/girar o bajo una espina ilíaca posterosuperior (EIPS)?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 39 años con dolor lumbar central de nueve meses, peor sentada y al inclinarse, sin dolor de pierna ni déficit.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Lumbalgia axial mecánica probablemente discogénica, sin indicación de bloqueo de rama medial (MBB), epidural ni discografía rutinaria. El objetivo es restaurar tolerancia a carga y sedestación.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Se centraliza o peripheraliza con movimientos repetidos? ¿Sueño, miedo, trabajo y pausas?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Fiebre, cáncer, trauma, rigidez inflamatoria o dolor nocturno no mecánico?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Lumbalgia axial mecánica probablemente discogénica, sin indicación de bloqueo de rama medial (MBB), epidural ni discografía rutinaria. El objetivo es restaurar tolerancia a carga y sedestación.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Flexión y sedestación prolongada reproducen dolor central; extensión-rotación apenas molesta.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Neurológico y tensión neural normales; clúster articulación sacroilíaca (SI) 1/5; cadera normal.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	resonancia magnética (RM) previa: deshidratación L4-L5 sin compresión. El hallazgo es frecuente y no demuestra generador.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Dolor discogénico/nociceptivo axial: patrón flexión-sedestación y exclusión de dianas vecinas lo hacen plausible, no seguro.
- Facetario: esperaríamos extensión, giro y bipedestación; no dominan.
- Sacroilíaco: faltan dolor bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS) y ≥ 3 pruebas de provocación.
- Nociplástico: valorar si el dolor se generaliza, existe hipersensibilidad, fatiga y baja concordancia; hoy no domina.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Lumbalgia axial mecánica probablemente discogénica, sin indicación de bloqueo de rama medial (MBB), epidural ni discografía rutinaria. El objetivo es restaurar tolerancia a carga y sedestación.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Lumbalgia axial mecánica probablemente discogénica, sin indicación de bloqueo de rama medial (MBB), epidural ni discografía rutinaria. El objetivo es restaurar tolerancia a carga y sedestación.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, pausas variables, exposición graduada a flexión/carga, fuerza de tronco-cadera y programa aeróbico.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No hay una técnica indicada de entrada. Si el tratamiento base fracasa, reabrir mecanismo, diana y certeza; no convertir el fracaso conservador en indicación automática de infiltración.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- antiinflamatorio no esteroideo (AINE) corto solo si seguro; evitar opioide crónico. Tratar sueño y miedo si perpetúan.
- Si cambia el mapa, aparece déficit o fracasa un programa bien ejecutado, volver a fenotipar antes de pedir otra técnica.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisión a 6 semanas con minutos sentada, levantamientos tolerados y índice de discapacidad de Oswestry (ODI)/actividad elegida. Salida: alta a autocuidado cuando maneje brotes; derivación multidisciplinar si dominan C-D-E.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Tras tratamiento de carga aparece dolor distal con déficit neurológico.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Cuando cambia el fenotipo, hay que abandonar la etiqueta discogénica y repetir el examen neurológico.

Error frecuente Convertir una protrusión o deshidratación en diagnóstico causal y ofrecer una epidural para dolor exclusivamente axial.

Caso 13. Claudicación vascular que imita estenosis lumbar

Presentación Varón de 72 años, fumador, con dolor de pantorrillas a los 180 metros. Una resonancia magnética (RM) muestra estenosis lumbar moderada.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Cede al sentarse o basta con detenerse de pie? ¿Influye inclinarse o ir en bicicleta?	Paciente: Me basta con quedarme quieto de pie; no necesito sentarme.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Friedad, heridas, dolor nocturno distal, tabaquismo, diabetes o enfermedad vascular?	Paciente: El carrito no cambia la distancia.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿El umbral de marcha es constante? ¿Hay síntomas por encima de rodillas o debilidad neurológica?	Paciente: El dolor está sobre todo en las pantorrillas y aparece casi siempre a la misma distancia.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Claudicación vascular. La mejor «técnica de dolor» es no realizar una epidural y activar el circuito vascular. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Tratar la resonancia magnética (RM) en lugar de la constelación clínica y someter a epidural a un paciente con isquemia.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A - Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Cede al sentarse o basta con detenerse de pie? ¿Influye inclinarse o ir en bicicleta?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 72 años, fumador, con dolor de pantorrillas a los 180 metros. Una resonancia magnética (RM) muestra estenosis lumbar moderada.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Claudicación vascular. La mejor «técnica de dolor» es no realizar una epidural y activar el circuito vascular.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Friedad, heridas, dolor nocturno distal, tabaquismo, diabetes o enfermedad vascular?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿El umbral de marcha es constante? ¿Hay síntomas por encima de rodillas o debilidad neurológica?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Claudicación vascular. La mejor «técnica de dolor» es no realizar una epidural y activar el circuito vascular.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	El dolor cede en 2-3 minutos al quedarse quieto de pie; flexionarse no añade alivio. Bicicleta también provoca a carga suficiente.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Pies fríos, pulsos pedios débiles, relleno lento; índice tobillo-brazo (ITB) 0,62. Neurológico normal y extensión lumbar no reproduce.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	La resonancia magnética (RM) es un hallazgo anatómico discordante con el fenotipo dominante.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Enfermedad arterial periférica: umbral constante, pantorrilla, alivio al detenerse e índice tobillo-brazo (ITB) patológico la hacen dominante.
- Estenosis lumbar: el carrito, flexión y sedestación ayudarían; puede coexistir, pero hoy no explica mejor.
- Neuropatía: sería menos reproducible por distancia y más persistente en reposo.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Claudicación vascular. La mejor «técnica de dolor» es no realizar una epidural y activar el circuito vascular.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Claudicación vascular. La mejor «técnica de dolor» es no realizar una epidural y activar el circuito vascular.»
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Derivación vascular priorizada según gravedad; control de tabaco, TA, lípidos, diabetes y ejercicio supervisado por equipo responsable.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No hay una técnica indicada de entrada. Si el tratamiento base fracasa, reabrir mecanismo, diana y certeza; no convertir el fracaso conservador en indicación automática de infiltración.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Analgesia prudente sin ocultar isquemia; cuidado de pies.
- Si tras tratamiento vascular persiste un segundo patrón postural, reevaluar estenosis con prueba de marcha.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Seguimiento coordinado; registrar distancia hasta dolor y lesiones cutáneas. Urgente si dolor de reposo nuevo, frialdad aguda, palidez, pérdida de pulso o déficit.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La resonancia magnética muestra estenosis lumbar severa.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Una imagen llamativa no desplaza un síndrome vascular concordante; ambas enfermedades pueden coexistir.

Error frecuente Tratar la resonancia magnética (RM) en lugar de la constelación clínica y someter a epidural a un paciente con isquemia.

Caso 14. Sospecha de cola de caballo: la consulta que se interrumpe

Presentación Mujer de 51 años con sciática bilateral intensa y dificultad para orinar desde la noche anterior.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Retención, incontinencia por rebosamiento o cambio de sensación al orinar?	Paciente: Desde ayer me cuesta empezar a orinar y noto dormida la zona perineal.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Anestesia en silla de montar, función sexual, debilidad bilateral o cambio de marcha?	Paciente: La pierna se ha debilitado en horas.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Inicio y progresión? ¿Cirugía, cáncer, infección o anticoagulación?	Paciente: El dolor es bilateral y distinto de mis episodios previos.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Sospecha de cola de caballo. Se suspende la consulta ordinaria y se activa evaluación urgente con resonancia magnética (RM) y equipo espinal. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Completar una consulta de dolor, pedir una resonancia magnética (RM) ambulatoria o probar una infiltración ante síntomas de cola de caballo.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Retención, incontinencia por rebosamiento o cambio de sensación al orinar?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 51 años con sciática bilateral intensa y dificultad para orinar desde la noche anterior.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Sospecha de cola de caballo. Se suspende la consulta ordinaria y se activa evaluación urgente con resonancia magnética (RM) y equipo espinal.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Anestesia en silla de montar, función sexual, debilidad bilateral o cambio de marcha?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Inicio y progresión? ¿Cirugía, cáncer, infección o anticoagulación?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Sospecha de cola de caballo. Se suspende la consulta ordinaria y se activa evaluación urgente con resonancia magnética (RM) y equipo espinal.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	No siente bien el paso de orina y necesita pujar; hipoestesia perineal nueva.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Flexión plantar 4-/5 bilateral, aquíleos reducidos; elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) bilateral. No se demora la derivación para completar maniobras dolorosas.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Una exploración rectal aislada normal no excluiría el síndrome.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Compresión de cola de caballo: la combinación de disfunción vesical, anestesia perineal y déficit bilateral es una emergencia.
- Dolor radicular bilateral sin CES: no explicaría alteración esfinteriana/silla de montar.
- Infección, hematoma o tumor: son causas compresivas alternativas; antecedentes modifican urgencia e imagen, no la necesidad de actuar.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Sospecha de cola de caballo. Se suspende la consulta ordinaria y se activa evaluación urgente con resonancia magnética (RM) y equipo espinal.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Sospecha de cola de caballo. Se suspende la consulta ordinaria y se activa evaluación urgente con resonancia magnética (RM) y equipo espinal.».
Alianza	«Lo prioritario hoy es activar un circuito urgente; una infiltración podría retrasar el diagnóstico.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Documentar hora de inicio, síntomas vesicales, perineales y fuerza; contactar urgencias/cirugía espinal y organizar traslado.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

No iniciar un ensayo ambulatorio que retrase el circuito urgente. La analgesia, antibiótico o corticoide sistémico se decide dentro del protocolo específico después de obtener las muestras o la imagen que correspondan.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No administrar sedación ni realizar epidural. Analgesia solo dentro del circuito urgente y sin retrasar imagen.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si resonancia magnética (RM) descarta compresión, reabrir diferencial urológico/neurológico; no banalizar los síntomas.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

El seguimiento pertenece al circuito hospitalario; registrar tiempos de reconocimiento, imagen y valoración. Tras resolución, rehabilitación y control de secuelas vesicales, sexuales, motoras y dolor.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El paciente pregunta si puede esperar a una resonancia magnética ambulatoria.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Retención, anestesia perineal y déficit progresivo activan un circuito urgente; documentar y reducir la demora es el tratamiento.

Error frecuente Completar una consulta de dolor, pedir una resonancia magnética (RM) ambulatoria o probar una infiltración ante síntomas de cola de caballo.

Caso 15. Dolor sacroilíaco frente a cadera y faceta lumbar

Presentación Mujer de 46 años con dolor unilateral bajo la espina ilíaca posterosuperior (EIPS) tras embarazo, peor al girar en cama, subir escaleras y salir del coche.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Puede señalar el dolor con un dedo? ¿Es inguinal, lateral o bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS)?	Paciente: Señalo justo debajo de la espina ilíaca posterior; no es la ingle.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Duele al apoyo monopodal, girar en cama o estar de pie? ¿Irradia bajo rodilla?	Paciente: Me duele al girarme en la cama y al apoyar una pierna.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Psoriasis, uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), rigidez prolongada o fiebre?	Paciente: No baja al pie ni da hormigueo.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Síndrome doloroso sacroilíaco probable. El clúster orienta; si una intervención depende del diagnóstico, confirmar con inyección intraarticular guiada. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Diagnosticar por flexión, abducción y rotación externa de cadera (FABER) aislado o infiltrar a ciegas sin distinguir articulación, ligamentos posteriores y cadera.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Puede señalar el dolor con un dedo? ¿Es inguinal, lateral o bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS)?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 46 años con dolor unilateral bajo la espina ilíaca posterosuperior (EIPS) tras embarazo, peor al girar en cama, subir escaleras y salir del coche.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Síndrome doloroso sacroilíaco probable. El clúster orienta; si una intervención depende del diagnóstico, confirmar con inyección intraarticular guiada.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Duele al apoyo monopodal, girar en cama o estar de pie? ¿Irradia bajo rodilla?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Psoriasis, uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), rigidez prolongada o fiebre?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Síndrome doloroso sacroilíaco probable. El clúster orienta; si una intervención depende del diagnóstico, confirmar con inyección intraarticular guiada.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Fortin finger positivo bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS); thigh thrust, compresión y sacral thrust reproducen dolor habitual (3/5).	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	rotación interna (RI) de cadera completa; flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) sin ingle. Extensión-rotación lumbar no reproduce y neuro normal.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Sin rasgos inflamatorios sistémicos.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Dolor sacroilíaco mecánico: localización y clúster $\geq 3/5$ aumentan probabilidad.
- Coxopatía: faltan ingle, rotación interna (RI) limitada y función de calzado alterada.
- Facetario: el dolor está más bajo y no se reproduce con extensión-rotación.
- Espondiloartritis: se reconsidera si aparecen rigidez, alternancia glútea o manifestaciones extraarticulares.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Síndrome doloroso sacroilíaco probable. El clúster orienta; si una intervención depende del diagnóstico, confirmar con inyección intraarticular guiada.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Síndrome doloroso sacroilíaco probable. El clúster orienta; si una intervención depende del diagnóstico, confirmar con inyección intraarticular guiada.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, fuerza lumbopélvica/glútea y exposición a transferencias; cinturón selectivo como prueba funcional.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si dolor ≥ 3 meses y fracaso conservador: articulación sacroilíaca (SI) intraarticular (IA) guiada, volumen total habitual 2-3 mL; triamcinolona/metilprednisolona 40 mg o dexametasona 7,5 mg según protocolo [18].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si alivio diagnóstico claro pero breve y recurrencia, valorar radiofrecuencia (RF) de ramas laterales solo en unidad acreditada; no aplicar parámetros facetarios por analogía.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisar a 2-6 semanas: giro en cama, escaleras y apoyo monopodal. Si bloqueo no modifica las maniobras diana, abandonar la hipótesis antes de repetir.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El bloqueo intraarticular no cambia el giro en cama.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Una respuesta discordante obliga a revisar diana, técnica y diagnósticos vecinos; no programe radiofrecuencia por inercia.

Error frecuente Diagnosticar por flexión, abducción y rotación externa de cadera (FABER) aislado o infiltrar a ciegas sin distinguir articulación, ligamentos posteriores y cadera.

Caso 16. Radiculopatía cervical C6 frente a hombro doloroso

Presentación Varón de 50 años con dolor escapular y lateral de brazo hasta pulgar, inicialmente remitido por «tendinitis de hombro».

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿El dolor rebasa el codo? ¿Hormigueo en pulgar? ¿Cambia con cuello o al poner la mano sobre la cabeza?	Paciente: Baja por el brazo hasta el pulgar y a veces hormiguea.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Debilidad al flexionar codo o extender muñeca? ¿Torpeza, alteración de marcha o esfínteres?	Paciente: Mover el cuello lo reproduce; apoyar la mano sobre la cabeza a veces alivia.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿El movimiento pasivo del hombro reproduce el dolor habitual?	Paciente: No noto manos torpes ni cambios en la marcha.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Radiculopatía C6 sin mielopatía ni déficit progresivo. American College of Radiology (ACR) 2024 considera la resonancia magnética (RM) sin contraste apropiada cuando hay radiculopatía crónica [42]. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Infiltrar la bursa porque Hawkins duele ligeramente, ignorando el mapa distal y el examen neurológico.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿El dolor rebasa el codo? ¿Hormigueo en pulgar? ¿Cambia con cuello o al poner la mano sobre la cabeza?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 50 años con dolor escapular y lateral de brazo hasta pulgar, inicialmente remitido por «tendinitis de hombro».
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Radiculopatía C6 sin mielopatía ni déficit progresivo. American College of Radiology (ACR) 2024 considera la resonancia magnética (RM) sin contraste apropiada cuando hay radiculopatía crónica [42].
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Debilidad al flexionar codo o extender muñeca? ¿Torpeza, alteración de marcha o esfínteres?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿El movimiento pasivo del hombro reproduce el dolor habitual?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Radiculopatía C6 sin mielopatía ni déficit progresivo. American College of Radiology (ACR) 2024 considera la resonancia magnética (RM) sin contraste apropiada cuando hay radiculopatía crónica [42].
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Spurling reproduce brazo-pulgar; distracción alivia; prueba de tensión neural del miembro superior (ULTT) mediano concordante.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Extensión de muñeca 4+/5, bicipital/braquiorradial reducidos; sensibilidad pulgar disminuida.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Hombro activo y pasivo completos; Jobe provoca molestia local distinta. Sin signos de mielopatía.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Radiculopatía C6: trayecto, déficit, reflejos y pruebas cervicales convergen.
- Manguito: puede coexistir, pero no explica parestesia distal, reflejo ni Spurling.
- Neuropatía mediana: no suele incluir cuello/escápula ni reflejos; explorar atrapamiento distal.
- Mielopatía: buscar hiperreflexia, Hoffmann, marcha y manos torpes; cambiaría a circuito urgente.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Radiculopatía C6 sin mielopatía ni déficit progresivo. American College of Radiology (ACR) 2024 considera la resonancia magnética (RM) sin contraste apropiada cuando hay radiculopatía crónica [42].

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Radiculopatía C6 sin mielopatía ni déficit progresivo. American College of Radiology (ACR) 2024 considera la resonancia magnética (RM) sin contraste apropiada cuando hay radiculopatía crónica [42].».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, actividad, ejercicio cervical/escapular y analgesia prudente; reevaluación motora.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

En sciática no usar gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoide oral ni opioide crónico de rutina. Si se usa analgesia simple o antiinflamatorio no esteroideo, que sea un ensayo corto, con cribado renal/gastrointestinal/cardiovascular y objetivo funcional.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

resonancia magnética (RM) si persiste, hay déficit o se plantea intervención/cirugía. electromiografía (EMG) si duda raíz frente a nervio periférico. Cualquier epidural cervical exige especialista, fluoroscopia/contraste, esteroide no particulado y protocolo estricto; no se ofrece por una resonancia magnética (RM) sin concordancia [41,42].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Fuerza/reflejos a 2 semanas; función a 6 semanas. Derivación urgente si aparece mielopatía o progresión; espinal si dolor/déficit refractario concordante.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Aparecen torpeza de manos, hiperreflexia y marcha inestable.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La mielopatía cambia el circuito a valoración espinal prioritaria; una epidural ambulatoria deja de ser el plan.

Error frecuente Infiltrar la bursa porque Hawkins duele ligeramente, ignorando el mapa distal y el examen neurológico.

Caso 17. Rotura significativa del manguito frente a tendinopatía

Presentación Mujer de 66 años que tras una caída no puede elevar el brazo; antes tenía molestias leves pero conservaba función.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Pérdida inmediata de fuerza tras trauma? ¿Puede mantener el brazo si se lo colocan?	Paciente: Tras la caída perdí fuerza de inmediato y ya no puedo levantar el brazo.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Dolor nocturno previo, edad, dominancia y demanda? ¿Luxación?	Paciente: Si me lo colocan arriba, no consigo sostenerlo.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Parestesias o debilidad de deltoides que sugieran axilar/cervical?	Paciente: No tengo hormigueo, pero sí dolor nocturno.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Rotura traumática reparable hasta demostrar lo contrario. La prioridad es imagen adecuada y traumatología precoz, no una infiltración que retrase la decisión. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Confundir pseudoparesia traumática con «impingement» y repetir infiltraciones antes de definir reparabilidad.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Pérdida inmediata de fuerza tras trauma? ¿Puede mantener el brazo si se lo colocan?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 66 años que tras una caída no puede elevar el brazo; antes tenía molestias leves pero conservaba función.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Rotura traumática reparable hasta demostrar lo contrario. La prioridad es imagen adecuada y traumatología precoz, no una infiltración que retrase la decisión.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Dolor nocturno previo, edad, dominancia y demanda? ¿Luxación?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Parestesias o debilidad de deltoides que sugieran axilar/cervical?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Rotura traumática reparable hasta demostrar lo contrario. La prioridad es imagen adecuada y traumatología precoz, no una infiltración que retrase la decisión.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Elevación activa 35°, pasiva 160°; drop-arm y external rotation lag positivos. Deltoides contrae.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Jobe muestra debilidad verdadera, no solo dolor; cuello/neuro distal normales.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Radiografía sin fractura; ecografía sugiere rotura completa supra/infra con retracción.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Rotura traumática significativa: pseudoparesia, pasiva conservada y lag tras trauma son altamente preocupantes.
- Tendinopatía/subacromial: provoca arco doloroso, pero suele conservar capacidad y no produce lag franco.
- Capsulitis: limitaría también pasiva.
- Neuropatía axilar: afectaría deltoides y parche sensitivo lateral; explorar siempre tras trauma.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Rotura traumática reparable hasta demostrar lo contrario. La prioridad es imagen adecuada y traumatología precoz, no una infiltración que retrase la decisión.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Rotura traumática reparable hasta demostrar lo contrario. La prioridad es imagen adecuada y traumatología precoz, no una infiltración que retrase la decisión.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

resonancia magnética (RM) para tamaño, retracción, atrofia y plan quirúrgico; analgesia, movilidad pasiva segura y protección funcional.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si no es candidata a cirugía, plan compartido de rehabilitación; una bursa subacromial-subdeltoidea (SASD) de 20 mg de triamcinolona solo como ventana seleccionada y coordinada, nunca intratendinosa [1].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Evitar corticoide repetido y, especialmente, si se anticipa reparación; American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) advierte prudencia con múltiples inyecciones [28].

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Valoración traumatológica en plazo corto; medir elevación, lag y función. Si aparece rigidez pasiva secundaria, adaptar rehabilitación; no confundirla con diagnóstico inicial.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Se propone infiltrar para ganar tiempo antes de traumatología.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda En una rotura traumática reparable, una infiltración puede retrasar la decisión y no restaura la continuidad tendinosa.

Error frecuente Confundir pseudoparesia traumática con «impingement» y repetir infiltraciones antes de definir reparabilidad.

Caso 18. Coxalgia intraarticular frente a dolor lumbar referido

Presentación Varón de 64 años con dolor inguinal y anterior de muslo hasta rodilla, además de cambios degenerativos lumbares y de cadera en imagen.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Duele al ponerse calcetines, entrar al coche y girar? ¿O con tos, sedestación y trayecto bajo rodilla?	Paciente: El dolor principal está en la ingle y me cuesta ponerme calcetines y entrar en el coche.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Hay rigidez y pérdida de rotación interna (RI)? ¿Parestesias, reflejos o déficit?	Paciente: No baja al pie ni hay parestesias.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Cuál de los dos dolores es el habitual al explorar?	Paciente: Girar la cadera reproduce exactamente mi dolor.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Coxartrosis dominante. Si persiste duda antes de una decisión mayor, una infiltración intraarticular (IA) de anestésico local de bajo volumen puede actuar como prueba funcional. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Elegir entre columna y cadera por cuál imagen parece «más fea», sin reproducir el dolor habitual.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Duele al ponerse calcetines, entrar al coche y girar? ¿O con tos, sedestación y trayecto bajo rodilla?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 64 años con dolor inguinal y anterior de muslo hasta rodilla, además de cambios degenerativos lumbares y de cadera en imagen.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Coxartrosis dominante. Si persiste duda antes de una decisión mayor, una infiltración intraarticular (IA) de anestésico local de bajo volumen puede actuar como prueba funcional.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Hay rigidez y pérdida de rotación interna (RI)? ¿Parestesias, reflejos o déficit?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Cuál de los dos dolores es el habitual al explorar?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Coxartrosis dominante. Si persiste duda antes de una decisión mayor, una infiltración intraarticular (IA) de anestésico local de bajo volumen puede actuar como prueba funcional.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Calcetines/coche muy limitados; dolor inguinal con log-roll, flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) y rotación interna (RI) pasiva reducida.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Neurológico, elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) y femoral stretch normales; lumbar produce molestia distinta.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	radiografía (Rx): artrosis coxofemoral moderada; resonancia magnética (RM) lumbar con estenosis foraminal sin correlato clínico.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Coxartrosis sintomática: función, ingre y rango de movimiento (ROM) pasivo concuerdan con radiografía.
- Radiculopatía alta: faltan tensión neural, déficit y provocación lumbar.
- síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS): sería lateral, dolor al decúbito/palpación, con rotación interna (RI) más conservada.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Coxartrosis dominante. Si persiste duda antes de una decisión mayor, una infiltración intraarticular (IA) de anestésico local de bajo volumen puede actuar como prueba funcional.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Coxartrosis dominante. Si persiste duda antes de una decisión mayor, una infiltración intraarticular (IA) de anestésico local de bajo volumen puede actuar como prueba funcional.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Fuerza, aeróbico adaptado, peso si procede, bastón contralateral y antiinflamatorio no esteroideo (AINE) según riesgo.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si necesita ventana: intraarticular (IA) ecoguiada/fluoro con triamcinolona 40 mg + lidocaína 1% 2-3 mL, total 3-5 mL; registrar respuesta inmediata y a semanas [1].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Derivar a artroplastia por impacto funcional y fracaso de manejo, no por grado radiográfico aislado. radiofrecuencia (RF) femoral/obturadora solo si no operable y con evidencia más limitada.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2-6 semanas tras intraarticular (IA): calzado, coche y marcha; vigilar glucemia/infección. No repetir si la respuesta inmediata no confirmó cadera o el beneficio fue irrelevante.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La resonancia lumbar parece más grave que la radiografía de cadera.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La concordancia clínica pesa más que cuál imagen resulta más espectacular.

Error frecuente Elegir entre columna y cadera por cuál imagen parece «más fea», sin reproducir el dolor habitual.

Caso 19. Dolor patelofemoral frente a menisco y tendón rotuliano

Presentación Corredora de 27 años con dolor anterior de rodilla de inicio progresivo al aumentar cuestras y volumen.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Dolor retropatelar/peripatelar con sentadilla, escaleras y sedestación?	Paciente: Duele alrededor de la rótula al bajar escaleras, hacer sentadillas y después de estar sentada.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Hubo giro, derrame, bloqueo o dolor en interlínea?	Paciente: No hubo giro, derrame ni bloqueo.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿El punto máximo está en polo inferior/tendón y empeora con salto?	Paciente: Aumenté de golpe cuestras y kilómetros.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Dolor patelofemoral relacionado con sobrecarga. No necesita resonancia magnética (RM) ni infiltración como primera respuesta. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Solicitar resonancia magnética (RM) por dolor anterior inespecífico y tratar cualquier señal meniscal incidental.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Dolor retropatelar/peripatelar con sentadilla, escaleras y sedestación?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Corredora de 27 años con dolor anterior de rodilla de inicio progresivo al aumentar cuestas y volumen.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Dolor patelofemoral relacionado con sobrecarga. No necesita resonancia magnética (RM) ni infiltración como primera respuesta.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Hubo giro, derrame, bloqueo o dolor en interlínea?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿El punto máximo está en polo inferior/tendón y empeora con salto?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Dolor patelofemoral relacionado con sobrecarga. No necesita resonancia magnética (RM) ni infiltración como primera respuesta.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Dolor peripatelar con step-down y sentadilla; control pélvico pobre y aumento brusco de carga.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Sin derrame, bloqueo ni inestabilidad; McMurray/Thessaly no reproducen el dolor habitual.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Tendón rotuliano no es el punto máximo; rango de movimiento (ROM) completo.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Dolor patelofemoral: dolor anterior con carga en flexión y sedestación es el fenotipo clásico [38].
- Menisco: faltan trauma, interlínea, derrame y síntomas mecánicos verdaderos.
- Tendinopatía rotuliana: esperaríamos dolor focal del tendón con carga elástica/salto.
- Inestabilidad rotuliana: buscar luxación, aprehensión y factores anatómicos.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Dolor patelofemoral relacionado con sobrecarga. No necesita resonancia magnética (RM) ni infiltración como primera respuesta.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Dolor patelofemoral relacionado con sobrecarga. No necesita resonancia magnética (RM) ni infiltración como primera respuesta.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Reducir temporalmente cuestas/volumen sin reposo total; fuerza de cadera y rodilla, control de step-down y retorno gradual.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No infiltrar corticoide peripatellar ni indicar plasma rico en plaquetas (PRP) sin una diana tendinosa definida.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Taping u ortesis plantar como prueba corta si facilitan ejercicio; educar sobre recurrencia y dosificación.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

4-6 semanas: dolor en sentadilla, escaleras y volumen de carrera tolerado. Imagen si derrame, bloqueo, trauma, fracaso atípico o sospecha estructural alternativa.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La paciente solicita una resonancia magnética y plasma rico en plaquetas antes de intentar carga.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda El dolor patelofemoral típico se trata primero con dosificación de carga y fuerza; una prueba o sustancia no sustituye el mecanismo.

Error frecuente Solicitar resonancia magnética (RM) por dolor anterior inespecífico y tratar cualquier señal meniscal incidental.

Caso 20. Rodilla caliente: sepsis frente a cristales y brote artrósico

Presentación Mujer de 73 años con gonartrosis, diabetes y dolor intenso de rodilla desde hace 24 horas, con derrame y calor.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Fiebre, escalofríos, infección reciente, herida, bacteriemia, prótesis o infiltración?	Paciente: Empezó en horas; la rodilla está caliente y tengo febrícula.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Antecedentes de gota/condrocalcinosis? ¿Inicio en horas?	Paciente: No recuerdo traumatismo, pero soy diabética.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Inmunosupresión o antibiótico que pueda ocultar fiebre?	Paciente: Nunca había tenido un derrame así.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Monoartritis aguda potencialmente séptica. La técnica indicada es artrocentesis diagnóstica urgente, no infiltración terapéutica. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Inyectar corticoide porque la paciente ya tenía artrosis o porque se observan cristales.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Fiebre, escalofríos, infección reciente, herida, bacteriemia, prótesis o infiltración?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 73 años con gonartrosis, diabetes y dolor intenso de rodilla desde hace 24 horas, con derrame y calor.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Monoartritis aguda potencialmente séptica. La técnica indicada es artrocentesis diagnóstica urgente, no infiltración terapéutica.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Antecedentes de gota/condrocalcinosis? ¿Inicio en horas?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Inmunosupresión o antibiótico que pueda ocultar fiebre?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Monoartritis aguda potencialmente séptica. La técnica indicada es artrocentesis diagnóstica urgente, no infiltración terapéutica.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Inflamatorio/infeccioso hasta completar el diagnóstico.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Rodilla caliente, gran derrame, rango de movimiento (ROM) muy doloroso y mal estado; la ausencia de fiebre alta no tranquiliza.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Ecografía confirma derrame y ayuda a aspirar; no se inyecta corticoide.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Líquido para recuento/diferencial, Gram, cultivo y cristales; hemocultivos si sepsis. Cristales no excluyen infección [39].	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Artritis séptica: debe excluirse primero; ningún dato clínico ni proteína C reactiva (PCR) normal la descarta [39].
- Artritis por cristales: inicio brusco y cristales apoyarían, pero puede coexistir con sepsis.
- Brote artrósico: es diagnóstico de menor riesgo solo tras excluir causas graves.
- Hemartros: considerar anticoagulación, trauma y aspecto del aspirado.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Monoartritis aguda potencialmente séptica. La técnica indicada es artrocentesis diagnóstica urgente, no infiltración terapéutica.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Monoartritis aguda potencialmente séptica. La técnica indicada es artrocentesis diagnóstica urgente, no infiltración terapéutica.».
Alianza	«Lo prioritario hoy es activar un circuito urgente; una infiltración podría retrasar el diagnóstico.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Aspirar antes de antibiótico si la situación lo permite, obtener cultivos y activar traumatología/infecciosas; si sepsis, tratamiento inmediato tras muestras [39].

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

No iniciar un ensayo ambulatorio que retrase el circuito urgente. La analgesia, antibiótico o corticoide sistémico se decide dentro del protocolo específico después de obtener las muestras o la imagen que correspondan.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Aspirar antes de antibiótico si la situación lo permite, obtener cultivos y activar traumatología/infecciosas; si sepsis, tratamiento inmediato tras muestras [39].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- No confiar en un umbral aislado de leucocitos sinoviales; >50.000/μL sugiere, valores bajos no excluyen, especialmente inmunosupresión.
- Solo tras diagnóstico no infeccioso confirmado se decide tratamiento de cristales/artrosis según comorbilidad.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Seguimiento hospitalario hasta control de infección y función; documentar cultivo y drenaje. Tras el episodio, revisar factores de riesgo y evitar nueva infiltración hasta resolución completa.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El líquido sinovial contiene cristales.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Los cristales no excluyen infección concomitante; el cultivo sigue siendo decisivo si la sospecha permanece.

Error frecuente Inyectar corticoide porque la paciente ya tenía artrosis o porque se observan cristales.

Caso 21. Neuralgia postherpética frente a radiculopatía

Presentación Varón de 76 años con quemazón y dolor al roce en hemicituró torácico, tres meses después de herpes zóster.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Hubo erupción vesicular en el mismo territorio? ¿Dolor superficial al roce o profundo con columna?	Paciente: Tuve vesículas exactamente en esta franja y ahora duele hasta el roce de la camiseta.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Déficit motor, fiebre, pérdida de peso o nueva erupción?	Paciente: No hay debilidad ni dolor al mover la columna.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Función renal, caídas, cognición y fármacos sedantes?	Paciente: Tengo enfermedad renal y me preocupa caerme con medicación.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Neuralgia postherpética localizada. Aquí sí son aplicables las recomendaciones de dolor neuropático general; no confundir con la recomendación negativa de gabapentinoides en sciática [25]. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Prescribir dosis altas de gabapentinoide a un mayor sin ajuste renal, objetivo ni plan de retirada.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Hubo erupción vesicular en el mismo territorio? ¿Dolor superficial al roce o profundo con columna?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 76 años con quemazón y dolor al roce en hemicinturó torácico, tres meses después de herpes zóster.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Neuralgia postherpética localizada. Aquí sí son aplicables las recomendaciones de dolor neuropático general; no confundir con la recomendación negativa de gabapentinoides en sciática [25].
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Déficit motor, fiebre, pérdida de peso o nueva erupción?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Función renal, caídas, cognición y fármacos sedantes?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Neuralgia postherpética localizada. Aquí sí son aplicables las recomendaciones de dolor neuropático general; no confundir con la recomendación negativa de gabapentinoides en sciática [25].
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Cicatrices T8-T9 unilaterales sin cruzar línea media; alodinia marcada y pérdida sensitiva en el mismo campo.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Exploración axial no reproduce; sin déficit motor ni signos sistémicos.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	El sueño y la ropa son los objetivos funcionales principales.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Neuralgia postherpética: lesión previa y territorio cutáneo concordante demuestran dolor neuropático.
- Radiculopatía torácica: considerar si no hubo erupción, hay dolor axial, déficit o causa estructural.
- Recurrencia/infección activa: nuevas vesículas o inmunosupresión cambian el circuito.
- Dolor visceral: banderas digestivas/cardiopulmonares requieren estudio; no todo cinturó es neuralgia.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Neuralgia postherpética localizada. Aquí sí son aplicables las recomendaciones de dolor neuropático general; no confundir con la recomendación negativa de gabapentinoides en sciática [25].

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Neuralgia postherpética localizada. Aquí sí son aplicables las recomendaciones de dolor neuropático general; no confundir con la recomendación negativa de gabapentinoides en sciática [25].».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Lidocaína tópica 5% hasta 12 h/día sobre piel íntegra, especialmente si alodinia focal; educación de piel.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Elegir un solo ensayo según comorbilidad: duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; o amitriptilina 10 mg por la noche, habitualmente 10-50 mg, si el riesgo anticolinérgico/intervalo QT (QT)/caídas es bajo. Gabapentina 100-300 mg nocturnos con titulación y ajuste renal, o pregabalina 25-75 mg nocturnos/75 mg cada 12 h con ajuste renal, solo cuando estén indicadas. Revisar tolerancia a 2 semanas y eficacia funcional a 4-8; retirar gradualmente si fracasa. Lidocaína tópica 5%: hasta 12 h/día en piel íntegra y zona localizada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Bloqueos paravertebrales/intercostales no son rutina crónica; valorar solo en unidad experta con diana y objetivo definidos.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si precisa sistémico: elegir un agente por comorbilidad, p. ej. gabapentina con inicio bajo y ajuste renal, o duloxetine/antidepresivo tricíclico (TCA) si apropiado; titular y retirar si no mejora función.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2 semanas por tolerancia, 4-8 por eficacia: sueño, ropa, alodinia y caídas. Mantener solo si beneficio funcional supera sedación/carga farmacológica.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Gabapentina iniciada fuera de la unidad provoca confusión y una caída.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La elección debe adaptarse a riñón, fragilidad y objetivo; primera línea no significa apropiada para todos.

Error frecuente Prescribir dosis altas de gabapentinoide a un mayor sin ajuste renal, objetivo ni plan de retirada.

Caso 22. Síndrome de dolor regional complejo tras fractura

Presentación Mujer de 42 años con dolor regional desproporcionado, edema y dificultad para usar la mano diez semanas tras fractura de radio ya consolidada.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Dolor regional no limitado a un nervio? ¿Cambios de color/temperatura, sudor, edema, pelo/uñas y movimiento?	Paciente: El dolor ocupa toda la mano, cambia de color, suda y se hincha.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Qué signos están presentes hoy, no solo relatados?	Paciente: El roce es insoportable y temo moverla.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Infección, trombosis, compresión nerviosa, material o inmovilización explican mejor?	Paciente: No tengo fiebre ni herida abierta.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: síndrome de dolor regional complejo (SDRC) probable, diagnóstico clínico de exclusión. La prioridad es restaurar uso de la extremidad con un plan interdisciplinar temprano. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Etiquetar síndrome de dolor regional complejo (SDRC) por dolor intenso y edema sin aplicar Budapest ni excluir lesión nerviosa, infección o desuso.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A - Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Dolor regional no limitado a un nervio? ¿Cambios de color/temperatura, sudor, edema, pelo/uñas y movimiento?

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 42 años con dolor regional desproporcionado, edema y dificultad para usar la mano diez semanas tras fractura de radio ya consolidada.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	síndrome de dolor regional complejo (SDRC) probable, diagnóstico clínico de exclusión. La prioridad es restaurar uso de la extremidad con un plan interdisciplinar temprano.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Qué signos están presentes hoy, no solo relatados?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Infección, trombosis, compresión nerviosa, material o inmovilización explican mejor?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	síndrome de dolor regional complejo (SDRC) probable, diagnóstico clínico de exclusión. La prioridad es restaurar uso de la extremidad con un plan interdisciplinar temprano.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Síntomas en las cuatro categorías Budapest: sensitiva, vasomotora, sudomotora/edema y motora/trófica.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Signos actuales en tres categorías: alodinia/hiperalgesia; asimetría térmica/color; edema/sudor; rango de movimiento (ROM) reducido. Dolor regional no dermatomal.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Radiografía confirma consolidación; no fiebre ni colección; nervios periféricos explorados.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- síndrome de dolor regional complejo (SDRC) tipo I: cumple Budapest y no se identifica lesión nerviosa mayor [43,44].
- Neuropatía focal: seguiría territorio nervioso y pruebas electrofisiológicas; si existe lesión mayor, valorar tipo II.
- Infección/trombosis: calor y edema obligan a excluirlas; no cumplen el conjunto sensitivo-autonómico-motor.
- Desuso: explica rigidez, no necesariamente alodinia y cambios autonómicos completos.

7. Formulación del experto y grado de certeza

síndrome de dolor regional complejo (SDRC) probable, diagnóstico clínico de exclusión. La prioridad es restaurar uso de la extremidad con un plan interdisciplinar temprano.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: síndrome de dolor regional complejo (SDRC) probable, diagnóstico clínico de exclusión. La prioridad es restaurar uso de la extremidad con un plan interdisciplinar temprano.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, terapia ocupacional/fisioterapia con desensibilización, imaginación motora graduada y exposición funcional; evitar inmovilización prolongada.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Bloqueo simpático no diagnostica síndrome de dolor regional complejo (SDRC) ni se repite por rutina; si se usa, debe crear una ventana funcional verificable. Neuromodulación solo tras programa especializado y selección.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Fármaco neuropático como ensayo medido si facilita terapia; revisar salud ósea y estado psicológico sin psicologizar el diagnóstico.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisión frecuente, inicialmente 2-4 semanas: rango de movimiento (ROM), uso, edema, discriminación y objetivos de mano. Escalar a unidad interdisciplinar si no progresa o hay deterioro; documentar criterios Budapest longitudinalmente.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Un bloqueo baja el dolor, pero la paciente continúa sin usar la mano.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La técnica solo tiene valor si abre una ventana de rehabilitación y exposición funcional.

Error frecuente Etiquetar síndrome de dolor regional complejo (SDRC) por dolor intenso y edema sin aplicar Budapest ni excluir lesión nerviosa, infección o desuso.

Caso 23. Dolor nociplástico generalizado: cuándo dejar de buscar dianas

Presentación Mujer de 48 años con dolor axial y periférico cambiante, fatiga, sueño no reparador y numerosas infiltraciones sin beneficio sostenido.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Dolor en varias regiones y sensibilidad generalizada? ¿Fatiga, niebla cognitiva y sueño?	Paciente: El dolor cambia de sitio, duermo mal y me levanto agotada.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Hay una nueva diana focal con signos objetivos o solo hallazgos degenerativos dispersos?	Paciente: Ninguna infiltración ha permitido una mejoría mantenida.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Qué miedo, expectativas, ánimo, trabajo y carga familiar mantienen discapacidad?	Paciente: Quiero volver a caminar veinte minutos sin acabar exhausta.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Fenotipo nociplástico dominante sin diana invasiva. La decisión correcta es detener la cascada de pruebas/técnicas y construir rehabilitación interdisciplinar. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Seguir buscando una estructura que justifique todo el sufrimiento y repetir técnicas porque alguna imagen muestra degeneración.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Dolor en varias regiones y sensibilidad generalizada? ¿Fatiga, niebla cognitiva y sueño?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 48 años con dolor axial y periférico cambiante, fatiga, sueño no reparador y numerosas infiltraciones sin beneficio sostenido.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Fenotipo nociplástico dominante sin diana invasiva. La decisión correcta es detener la cascada de pruebas/técnicas y construir rehabilitación interdisciplinar.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Hay una nueva diana focal con signos objetivos o solo hallazgos degenerativos dispersos?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Qué miedo, expectativas, ánimo, trabajo y carga familiar mantienen discapacidad?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Fenotipo nociplástico dominante sin diana invasiva. La decisión correcta es detener la cascada de pruebas/técnicas y construir rehabilitación interdisciplinar.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociplástico predominante; no existe diana única.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Mapa amplio, hipersensibilidad y baja concordancia anatómica; neurología normal, sin sinovitis ni banderas rojas.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	ABCDE: B nociplástico, C miedo/catastrofismo, D sueño-fatiga-discapacidad y E conflicto laboral; A no ofrece diana dominante.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 3	Analítica e imagen previas no revelan enfermedad explicativa; se revisan para evitar duplicación, sin negar el dolor.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Dolor nociplástico/fibromialgia: conjunto de dolor generalizado, sueño, fatiga e hipersensibilidad; ejercicio es la recomendación terapéutica fuerte de EULAR [40].
- Enfermedad inflamatoria: buscar sinovitis, rigidez prolongada, reactantes y manifestaciones sistémicas; no se excluye por etiqueta previa.
- Neuropatía de fibra fina: considerar si síntomas autonómicos/neuropáticos claros; no explica automáticamente todo el cuadro.
- Trastorno depresivo: puede modular y necesita tratamiento, pero no convierte el dolor en imaginario.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Fenotipo nociplástico dominante sin diana invasiva. La decisión correcta es detener la cascada de pruebas/técnicas y construir rehabilitación interdisciplinar.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Fenotipo nociplástico dominante sin diana invasiva. La decisión correcta es detener la cascada de pruebas/técnicas y construir rehabilitación interdisciplinar.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Explicación compartida no estigmatizante; objetivos de energía, sueño y participación, no promesa de escala numérica del dolor (NRS) cero.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

No añadir analgésicos por inercia ni opioides. Priorizar actividad, sueño y terapia psicológica del dolor; un antidepresivo se decide por indicación y comorbilidad, con dosis, objetivo y retirada explícitos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Revisar y deprescribir fármacos ineficaces/sedantes; duloxetina u otra opción solo por fenotipo/comorbilidad, con ensayo y retirada. Evitar opioide y nuevas infiltraciones sin diana.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Actividad aeróbica y fuerza desde dosis tolerable, progresión lenta; terapia psicológica si miedo/afrontamiento o ánimo lo requieren.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Cada 4-8 semanas: función, actividad, sueño, fatiga y carga farmacológica. Plan de brote por escrito para evitar urgencias repetidas; reabrir diagnóstico si aparecen signos focales nuevos.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Una nueva resonancia muestra protrusiones leves y la paciente solicita epidural.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Un hallazgo incidental no crea una diana ni una indicación intervencionista.

Error frecuente Seguir buscando una estructura que justifique todo el sufrimiento y repetir técnicas porque alguna imagen muestra degeneración.

Caso 24. Dolor vertebral en paciente oncológico: sospecha de compresión metastásica

Presentación Varón de 69 años con cáncer de próstata, dolor dorsal progresivo nocturno y nueva torpeza al caminar.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Dolor intenso continuo, nocturno, con tos o localizado a percusión?	Paciente: Tengo cáncer y el dolor dorsal empeora cada noche.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Debilidad, marcha, nivel sensitivo, esfínteres o radiculalgia?	Paciente: Desde esta semana camino peor y noto una banda dormida.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Diagnóstico oncológico actual/pasado y tratamientos? ¿Velocidad de progresión?	Paciente: No he perdido aún el control de esfínteres.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Sospecha de compresión medular metastásica (MSCC). Contacto inmediato con coordinador/equipo oncológico-espinal, protección de columna y resonancia magnética (RM) urgente; la consulta de dolor se interrumpe. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Atribuir el dolor a espondilosis conocida o programar una técnica ambulatoria ante signos de compresión medular.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Dolor intenso continuo, nocturno, con tos o localizado a percusión?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 69 años con cáncer de próstata, dolor dorsal progresivo nocturno y nueva torpeza al caminar.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Sospecha de compresión medular metastásica (MSCC). Contacto inmediato con coordinador/equipo oncológico-espinal, protección de columna y resonancia magnética (RM) urgente; la consulta de dolor se interrumpe.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Debilidad, marcha, nivel sensitivo, esfínteres o radiculalgia?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Diagnóstico oncológico actual/pasado y tratamientos? ¿Velocidad de progresión?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Sospecha de compresión medular metastásica (MSCC). Contacto inmediato con coordinador/equipo oncológico-espinal, protección de columna y resonancia magnética (RM) urgente; la consulta de dolor se interrumpe.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Dolor focal dorsal, progresivo y nocturno; marcha inestable e hiperreflexia en piernas.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 2	No se fuerza exploración ni movilización dolorosa si se sospecha inestabilidad.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	La radiografía simple no sirve para excluir metástasis/compresión; NICE recomienda resonancia magnética (RM) urgente y siempre dentro de 24 h si se sospecha compresión medular metastásica (MSCC) [45].	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Compresión medular metastásica: cáncer + dolor progresivo + signos neurológicos es emergencia oncológica.
- Fractura patológica/inestabilidad: dolor mecánico focal y carga; puede coexistir y condiciona inmovilización.
- Espondilodiscitis: fiebre puede faltar; inmunosupresión y reactantes/cultivos orientan.
- Dolor degenerativo: no debe asumirse ante progresión nocturna y signos medulares.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Sospecha de compresión medular metastásica (MSCC). Contacto inmediato con coordinador/equipo oncológico-espinal, protección de columna y resonancia magnética (RM) urgente; la consulta de dolor se interrumpe.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Sospecha de compresión medular metastásica (MSCC). Contacto inmediato con coordinador/equipo oncológico-espinal, protección de columna y resonancia magnética (RM) urgente; la consulta de dolor se interrumpe.».
Alianza	«Lo prioritario hoy es activar un circuito urgente; una infiltración podría retrasar el diagnóstico.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Organizar traslado y comunicar hora, nivel neurológico y progresión; inmovilizar si hay signos de inestabilidad/neurología según protocolo [45].

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

No iniciar un ensayo ambulatorio que retrase el circuito urgente. La analgesia, antibiótico o corticoide sistémico se decide dentro del protocolo específico después de obtener las muestras o la imagen que correspondan.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Analgesia y corticoide sistémico solo dentro del protocolo oncológico; no realizar epidural, bloqueo ni radiofrecuencia (RF) paliativa antes de estabilizar/definir compresión.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Tras diagnóstico, plan multidisciplinar: cirugía, radioterapia, tratamiento sistémico y rehabilitación. Las técnicas paliativas se consideran después, con estabilidad y objetivos claros.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Seguimiento coordinado de neurología, dolor, función, esfínteres y toxicidad del tratamiento. Registrar tiempo a contacto, resonancia magnética (RM) y tratamiento; no limitar seguimiento a intensidad de dolor.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Existe una resonancia lumbar reciente sin cambios.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Una prueba de otra región o anterior a la progresión no descarta compresión dorsal nueva.

Error frecuente Atribuir el dolor a espondilosis conocida o programar una técnica ambulatoria ante signos de compresión medular.

Caso 25. Dolor de cadera o sacroilíaca: decisión con hallazgos coexistentes

Presentación Mujer de 59 años con dolor derecho en ingle y glúteo, peor al salir del coche, girar en cama y subir escaleras. La radiografía muestra artrosis leve de cadera.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Puede señalar dónde comienza: ingle, lateral o bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS)?	Paciente: A veces es inguinal al ponerme el calcetín y otras veces posterior al girarme en cama.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Qué tarea reproduce mejor el dolor habitual: calcetines/coche, decúbito, apoyo o tos?	Paciente: No tengo parestesias ni tos dolorosa.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Hay rigidez de cadera, irradiación bajo rodilla, parestesias o rasgos inflamatorios?	Paciente: Quiero saber cuál de los dos dolores limita realmente mi marcha.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Síndrome sacroilíaco probable como diana principal, con cambios leves de cadera posiblemente secundarios. Un clúster positivo no basta para confirmar [48]; si la decisión es invasiva, se valida con bloqueo guiado y tarea diana. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Infiltrar cadera y articulación sacroilíaca (SI) el mismo día: impide saber qué estructura explicaba el dolor y favorece repeticiones sin diagnóstico.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Puede señalar dónde comienza: ingle, lateral o bajo espina iliaca posterosuperior (EIPS)?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 59 años con dolor derecho en ingle y glúteo, peor al salir del coche, girar en cama y subir escaleras. La radiografía muestra artrosis leve de cadera.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Síndrome sacroiliaco probable como diana principal, con cambios leves de cadera posiblemente secundarios. Un clúster positivo no basta para confirmar [48]; si la decisión es invasiva, se valida con bloqueo guiado y tarea diana.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Qué tarea reproduce mejor el dolor habitual: calcetines/coche, decúbito, apoyo o tos?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Hay rigidez de cadera, irradiación bajo rodilla, parestesias o rasgos inflamatorios?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Síndrome sacroiliaco probable como diana principal, con cambios leves de cadera posiblemente secundarios. Un clúster positivo no basta para confirmar [48]; si la decisión es invasiva, se valida con bloqueo guiado y tarea diana.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	El dolor principal está bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS); la molestia inguinal es secundaria. Calcetines casi normales, pero girar en cama y apoyo monopodal reproducen el dolor principal.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	rotación interna (RI) de cadera solo discretamente reducida; log-roll y flexión, aducción y rotación interna de cadera (FADIR) producen molestia inguinal leve distinta.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Thigh thrust, compresión y sacral thrust reproducen exactamente el dolor habitual (3/5). Neuro y tensión neural normales; palpación trocantérica negativa.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Dolor sacroilíaco mecánico: la localización bajo espina ilíaca posterosuperior (EIPS), tareas de transferencia y clúster concordante lo hacen dominante.
- Coxartrosis leve sintomática: puede coexistir y explicar la ingle, pero no reproduce el dolor principal ni la mayor limitación.
- síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS): faltan dolor lateral, decúbito y palpación/abducción positivas.
- Raíz L4/L5: no hay trayecto distal, déficit, reflejo ni tensión neural.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Síndrome sacroilíaco probable como diana principal, con cambios leves de cadera posiblemente secundarios. Un clúster positivo no basta para confirmar [48]; si la decisión es invasiva, se valida con bloqueo guiado y tarea diana.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Síndrome sacroilíaco probable como diana principal, con cambios leves de cadera posiblemente secundarios. Un clúster positivo no basta para confirmar [48]; si la decisión es invasiva, se valida con bloqueo guiado y tarea diana.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Programa lumbopélvico/glúteo y exposición a giro/apoyo durante 6 semanas; tratar la función, no la radiografía.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si persiste: bloqueo/infiltración articulación sacroilíaca (SI) intraarticular (IA) guiada con bajo volumen. Si terapéutica, 2-3 mL total y corticoide de baja dosis según protocolo, por ejemplo triamcinolona 40 mg [18].

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Durante la ventana anestésica repetir giro en cama simulado, escalón y apoyo. Si no cambian, abandonar articulación sacroilíaca (SI) y reevaluar cadera; una intraarticular (IA) de cadera selectiva puede ser el siguiente test, no dos inyecciones simultáneas.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Diario inmediato tras bloqueo y revisión a 2-6 semanas. Éxito: giro en cama, escaleras y apoyo mejoran; si solo baja escala numérica del dolor (NRS) en reposo, no confirma una diana útil.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La infiltración de cadera alivia la ingle, pero persiste el dolor posterior al girarse.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Una respuesta parcial puede revelar dos generadores; se debe reformular, no

declarar fracaso global.

Error frecuente Infiltrar cadera y articulación sacroilíaca (SI) el mismo día: impide saber qué estructura explicaba el dolor y favorece repeticiones sin diagnóstico.

Caso 26. Irradiación lumbar: L5 frente a S1 sin fiarse solo del dermatoma

Presentación Varón de 47 años con dolor desde glúteo por cara posterolateral de pierna hasta el pie. Señala tanto dorso como borde lateral y pregunta si es L5 o S1.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Cuál es el punto más distal y dónde hay adormecimiento objetivo: primer espacio, borde lateral o planta?	Paciente: A veces va al dorso del pie y otras al borde lateral; no sabría dibujarlo con precisión.	Experto: Actualiza el patrón y la hipótesis anatómica; todavía no confirma la diana.
Médico: ¿Falla al caminar de talones o al hacer puntillas repetidas? ¿Se tuerce el tobillo?	Paciente: Me cuesta caminar de talones más que de puntillas.	Experto: Busca déficit, imitador o dato que cambie el nivel de prioridad.
Médico: ¿Tos/elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) reproducen el dolor? ¿Qué reflejo cambia?	Paciente: La tos y la elevación de la pierna reproducen el dolor.	Experto: Define la decisión siguiente y evita pedir pruebas sin una pregunta clínica.

Pensamiento del experto Mi formulación provisional es: Radiculopatía L5 derecha. Se localiza por convergencia, no por una franja roja en un mapa. El nivel discal L4-L5 y la raíz L5 no son nombres intercambiables. Antes de tratar busco el dato que podría refutarla. Evito este error: Decidir L5 o S1 por el dibujo mostrado al paciente, sin explorar primer espacio, extensor largo del dedo gordo (EHL), puntillas, aquileo y la anatomía exacta de la resonancia magnética (RM).

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	¿Cuál es el punto más distal y dónde hay adormecimiento objetivo: primer espacio, borde lateral o planta?
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 47 años con dolor desde glúteo por cara posterolateral de pierna hasta el pie. Señala tanto dorso como borde lateral y pregunta si es L5 o S1.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Radiculopatía L5 derecha. Se localiza por convergencia, no por una franja roja en un mapa. El nivel discal L4-L5 y la raíz L5 no son nombres intercambiables.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	¿Falla al caminar de talones o al hacer puntillas repetidas? ¿Se tuerce el tobillo?
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	¿Tos/elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) reproducen el dolor? ¿Qué reflejo cambia?

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Radiculopatía L5 derecha. Se localiza por convergencia, no por una franja roja en un mapa. El nivel discal L4-L5 y la raíz L5 no son nombres intercambiables.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	El dibujo se solapa: dolor posterolateral hasta tobillo y dorso-lateral del pie; por sí solo no discrimina [46].	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 2	Hipoestesia máxima en primer espacio; extensor largo del dedo gordo (EHL) 4/5 y abducción de cadera 4+/5. Flexión plantar y 10 puntillas son simétricas.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Aquileo y rotuliano conservados. elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) reproduce el trayecto. resonancia magnética (RM): hernia posterolateral L4-L5 que comprime la raíz L5 atravesante; L5-S1 sin compresión S1.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Radiculopatía L5: primer espacio + extensor largo del dedo gordo (EHL)/abducción y lesión L4-L5 concordante forman una constelación.
- Radiculopatía S1: el componente posterior sugiere, pero faltan planta/borde lateral dominante, aquileo reducido y debilidad en puntillas/eversión.
- Neuropatía peronea: puede afectar dorso/extensor largo del dedo gordo (EHL), pero buscar Tinel en cabeza peroné; no explicaría elevación de la pierna recta o Lasègue (SLR) ni abducción de cadera.
- Dolor articulación sacroilíaca (SI) referido: puede llegar a muslo, pero no debe producir pérdida del primer espacio ni debilidad miotómica.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Radiculopatía L5 derecha. Se localiza por convergencia, no por una franja roja en un mapa. El nivel discal L4-L5 y la raíz L5 no son nombres intercambiables.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Radiculopatía L5 derecha. Se localiza por convergencia, no por una franja roja en un mapa. El nivel discal L4-L5 y la raíz L5 no son nombres intercambiables.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Si no hay déficit progresivo: actividad graduada, analgesia prudente y vigilancia de extensor largo del dedo gordo (EHL)/talones.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

En sciática no usar gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoide oral ni opioide crónico de rutina. Si se usa analgesia simple o antiinflamatorio no esteroideo, que sea un ensayo corto, con cribado renal/gastrointestinal/cardiovascular y objetivo funcional.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

resonancia magnética (RM) ya concordante. Si sciática aguda grave persiste: infiltración epidural transforaminal (TFESI) L5 con contraste en tiempo real, lidocaína 1% 1 mL de prueba y dexametasona 4-10 mg; total ≤ 4 mL [7,17]. Si extensor largo del dedo gordo (EHL) empeora, aparece pie caído o fracaso estructural: valoración espinal; no repetir epidural para ocultar progresión.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Fuerza extensor largo del dedo gordo (EHL), dorsiflexión, abducción y marcha de talones en 1-2 semanas. Tras técnica: dolor de pierna, sueño y función a 1-2 y 6 semanas; revisar diagnóstico si la respuesta no sigue la ventana esperada.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La distribución cutánea no es 'de libro', pero el extensor largo del dedo gordo se debilita progresivamente.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda El dermatoma es una pista; el déficit motor progresivo y la imagen concordante pesan más.

Error frecuente Decidir L5 o S1 por el dibujo mostrado al paciente, sin explorar primer espacio, extensor largo del dedo gordo (EHL), puntillas, aquileo y la anatomía exacta de la resonancia magnética (RM).

Caso 27. Dolor persistente tras cirugía lumbar: reformular antes de otra técnica

Presentación Mujer de 63 años con artrodesis L4-S1, dolor lumbar y de pierna recurrente, sueño pobre, miedo a moverse y varias infiltraciones de beneficio breve.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Qué tratamiento anterior le permitió hacer algo que antes no podía?	Paciente: Las infiltraciones bajaban el dolor unos días, pero no caminaba más.	Experto: Beneficio numérico sin función; no justifica repetir.
Médico: ¿Qué cree que ocurrirá si se mueve?	Paciente: Temo romper la artrodesis.	Experto: Miedo-evitación modificable; requiere educación y exposición.
Médico: ¿Ha aparecido debilidad, anestesia perineal o problema de esfínteres?	Paciente: No.	Experto: Permite circuito ordinario, manteniendo vigilancia.

Pensamiento del experto No debo convertir 'cirugía fallida' en una etiqueta que empuja a otra técnica. Primero separo lesión corregible, raíz activa, dolor axial, dolor neuropático y amplificación nociplástica.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Aparición: recurrencia gradual tras mejoría posquirúrgica inicial.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 63 años con artrodesis L4-S1, dolor lumbar y de pierna recurrente, sueño pobre, miedo a moverse y varias infiltraciones de beneficio breve.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Dolor crónico posquirúrgico mixto con discapacidad y moduladores nociplásticos; antes de neuromodulación debe excluirse una causa corregible y completarse una formulación interdisciplinar.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Localización e irradiación: lumbar más pierna, con componentes axial y neuropático.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Agravantes y atenuantes: desacondicionamiento, sueño y miedo-evitación; las técnicas previas ayudaron días sin mejorar función.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Dolor crónico posquirúrgico mixto con discapacidad y moduladores nociplásticos; antes de neuromodulación debe excluirse una causa corregible y completarse una formulación interdisciplinar.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociplástico predominante; no existe diana única.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Neurología estable y ausencia de déficit nuevo o signos de cola de caballo.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Dolor periincisional difuso, desacondicionamiento y conducta de protección.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Revisión de imagen dirigida a pseudoartrosis, infección, inestabilidad, estenosis adyacente o compresión corregible; no repetir imagen por rutina.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.
- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Dolor crónico posquirúrgico mixto con discapacidad y moduladores nociplásticos; antes de neuromodulación debe excluirse una causa corregible y completarse una formulación interdisciplinar.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Dolor crónico posquirúrgico mixto con discapacidad y moduladores nociplásticos; antes de neuromodulación debe excluirse una causa corregible y completarse una formulación interdisciplinar.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Explicar el dolor mixto, recuperar actividad gradual, sueño y exposición; psicología del dolor si miedo/catastrofismo mantienen discapacidad.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Elegir un solo ensayo según comorbilidad: duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; o amitriptilina 10 mg por la noche, habitualmente 10-50 mg, si el riesgo anticolinérgico/intervalo QT (QT)/caídas es bajo. Gabapentina 100-300 mg nocturnos con titulación y ajuste renal, o pregabalina 25-75 mg nocturnos/75 mg cada 12 h con ajuste renal, solo cuando estén indicadas. Revisar tolerancia a 2 semanas y eficacia funcional a 4-8; retirar gradualmente si fracasa. Lidocaína tópica 5%: hasta 12 h/día en piel íntegra y zona localizada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si componente neuropático demostrable: duloxetina 30 mg/día durante 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; revisar a 2 y 6 semanas y retirar gradualmente si no mejora función. No repetir epidural sin raíz/diana concordante. Considerar estimulación de la médula espinal (SCS) solo tras selección multidisciplinar, objetivo funcional, optimización farmacológica y ensayo según protocolo.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisión a 2 semanas de tolerancia y a 6-12 semanas de función: escala Pain, Enjoyment and General activity (PEG), índice de discapacidad de Oswestry (ODI), sueño, marcha, consumo de rescates y eventos. Si se plantea neuromodulación, documentar objetivo, prueba, complicaciones y plan de mantenimiento.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La paciente solicita un implante como 'último recurso', pero todavía no puede describir un objetivo funcional ni ha completado rehabilitación.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La neuromodulación no compensa una formulación incompleta. Selección, expectativas, objetivo funcional y seguimiento forman parte del tratamiento.

Caso 28. Cervicalgia facetaria y cefalea occipital frente a radiculopatía

Presentación Varón de 58 años con dolor cervical alto unilateral que asciende al occipucio, sin irradiación al brazo ni parestesias.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿El dolor baja al brazo o da hormigueo en los dedos?	Paciente: No; sube hacia la nuca.	Experto: Reduce radiculopatía cervical.
Médico: ¿Girar o extender el cuello reproduce exactamente el dolor?	Paciente: Sí, sobre todo hacia la derecha.	Experto: Apoya origen cervical mecánico, no confirma faceta.
Médico: ¿Hay cefalea súbita, fiebre, trauma o síntomas neurológicos?	Paciente: No.	Experto: Reduce causas secundarias urgentes.

Pensamiento del experto No llamo neuralgia occipital a cualquier dolor de nuca ni faceta a cualquier artrosis. Localizo el patrón, excluyo cefalea secundaria y solo uso un bloqueo si su resultado cambiará la conducta.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Aparición progresiva tras años de trabajo mantenido.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 58 años con dolor cervical alto unilateral que asciende al occipucio, sin irradiación al brazo ni parestesias.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Dolor cervical alto probablemente facetario con dolor referido occipital; neuralgia occipital en diferencial. La historia y exploración orientan, pero una radiofrecuencia exige bloqueo pronóstico apropiado.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Localización cervical alta y suboccipital; irradiación al cuero cabelludo posterior.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	No debilidad, alteración de marcha, fiebre, trauma ni síntomas vasculares.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Dolor cervical alto probablemente facetario con dolor referido occipital; neuralgia occipital en diferencial. La historia y exploración orientan, pero una radiofrecuencia exige bloqueo pronóstico apropiado.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Neurología de miembros superiores normal y ausencia de mielopatía.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Extensión-rotación reproduce dolor habitual; palpación del trayecto occipital puede provocar dolor, pero no distingue por sí sola faceta C2-C3 de neuralgia occipital.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Explorar hombro, articulación temporomandibular y banderas de cefalea secundaria.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.
- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Dolor cervical alto probablemente facetario con dolor referido occipital; neuralgia occipital en diferencial. La historia y exploración orientan, pero una radiofrecuencia exige bloqueo pronóstico apropiado.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Dolor cervical alto probablemente facetario con dolor referido occipital; neuralgia occipital en diferencial. La historia y exploración orientan, pero una radiofrecuencia exige bloqueo pronóstico apropiado.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Educación, ergonomía dinámica, movilidad y fuerza cervical/escapular; curso corto de naproxeno 250 mg cada 12 h si riesgo gastrointestinal, renal y cardiovascular aceptable.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

En sciática no usar gabapentinoides, benzodiacepinas, corticoide oral ni opioide crónico de rutina. Si se usa analgesia simple o antiinflamatorio no esteroideo, que sea un ensayo corto, con cribado renal/gastrointestinal/cardiovascular y objetivo funcional.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Educación, ergonomía dinámica, movilidad y fuerza cervical/escapular; curso corto de naproxeno 250 mg cada 12 h si riesgo gastrointestinal, renal y cardiovascular aceptable. Si se contempla radiofrecuencia: bloqueo de ramas mediales cervicales con volumen bajo, guía fluoroscópica y diario funcional; no infiltrar por una resonancia magnética

degenerativa aislada. Si respuesta concordante: radiofrecuencia térmica cervical según técnica validada y protocolo; evitar sedación profunda y vigilar riesgos neurológicos. Bloqueo occipital solo si el fenotipo y la diana lo apoyan.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisión 4-6 semanas conservadora; tras bloqueo, diario durante la ventana anestésica; tras radiofrecuencia, 2 y 6-8 semanas con rotación, conducción, sueño y cefalea.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso El bloqueo reduce un 80% el dolor en reposo, pero el paciente no prueba la rotación que lo desencadena.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Un bloqueo pronóstico debe retar la actividad diana durante su ventana. Sin concordancia funcional, la respuesta porcentual es insuficiente.

Caso 29. Dolor después de prótesis total de rodilla

Presentación Mujer de 70 años con prótesis total de rodilla desde hace 18 meses y dolor persistente anterior y medial; solicita radiofrecuencia genicular.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿La rodilla se ha calentado, hinchado o ha drenado?	Paciente: A veces se hincha, pero no ha drenado.	Experto: No excluye infección; obliga a valorar el contexto.
Médico: ¿Siente que falla o cambia la estabilidad?	Paciente: Sí, al bajar escaleras.	Experto: Posible inestabilidad mecánica; radiofrecuencia no la corrige.
Médico: ¿Qué espera conseguir con la técnica?	Paciente: Subir dos pisos y reducir rescates.	Experto: Objetivos medibles si finalmente es candidata.

Pensamiento del experto En una prótesis dolorosa la pregunta inicial no es dónde colocar la aguja, sino qué complicación o causa mecánica todavía no se ha excluido.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Dolor persistente desde la cirugía, con un periodo de mejoría parcial.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 70 años con prótesis total de rodilla desde hace 18 meses y dolor persistente anterior y medial; solicita radiofrecuencia genicular.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Prótesis dolorosa: diagnóstico etiológico pendiente. La radiofrecuencia genicular solo se considera después de excluir infección y causa mecánica corregible.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Localización anterior y medial; preguntar inicio, reposo, carga y dolor nocturno.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Agravantes: escaleras y levantarse; no fiebre declarada.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Prótesis dolorosa: diagnóstico etiológico pendiente. La radiofrecuencia genicular solo se considera después de excluir infección y causa mecánica corregible.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Temperatura, derrame, cicatriz, rango, estabilidad, marcha, alineación y exploración neurovascular.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Radiografías en carga y comparación; descartar aflojamiento, fractura, mala alineación e inestabilidad.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Si hay sospecha de infección: proteína C reactiva/velocidad de sedimentación y aspiración según circuito; no infiltrar corticoide en la prótesis.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.

- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Prótesis dolorosa: diagnóstico etiológico pendiente. La radiofrecuencia genicular solo se considera después de excluir infección y causa mecánica corregible.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Prótesis dolorosa: diagnóstico etiológico pendiente. La radiofrecuencia genicular solo se considera después de excluir infección y causa mecánica corregible.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Coordinar con artroplastia; fisioterapia dirigida al déficit identificado y analgesia no opioide según comorbilidad.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h si se utiliza, con máximo habitual de 3 g/día y menor techo en fragilidad/hepatopatía; evitar escalar opioide sin diagnóstico. Si infección y causa mecánica se excluyen, dolor nociceptivo persiste y no hay opción correctora: bloqueo genicular de bajo volumen; si es concordante, radiofrecuencia térmica 70-80 °C durante 90-180 s por diana según protocolo y anatomía individual.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

No proceder a radiofrecuencia hasta completar estudio. Si se realiza, revisar a 2 y 6-8 semanas: escaleras, levantarse, marcha, analgesia y neuritis/hipoestesia.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Antes del bloqueo aparece derrame nuevo y aumento de proteína C reactiva.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La diana cambia a diagnóstico de infección. Una técnica analgésica nunca debe silenciar una prótesis potencialmente infectada.

Caso 30. Meralgia parestésica frente a radiculopatía lumbar alta

Presentación Varón de 49 años con quemazón y adormecimiento en cara anterolateral del muslo, peor con cinturón y bipedestación; sin dolor lumbar.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Nota debilidad al subir escaleras o que falle la rodilla?	Paciente: No; solo ardor y zona dormida.	Experto: Favorece nervio puramente sensitivo.
Médico: ¿El dolor baja por debajo de la rodilla?	Paciente: No.	Experto: Reduce radiculopatía lumbar.
Médico: ¿Qué ocurre al aflojar el cinturón?	Paciente: Mejora en minutos.	Experto: Apoya compresión periférica.

Pensamiento del experto El mapa orienta, pero confirmo que no hay miotoma ni reflejo alterados. Si aparecen, el diagnóstico deja de ser una meralgia simple.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Inicio tras aumento de peso y uso de cinturón de herramientas.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 49 años con quemazón y adormecimiento en cara anterolateral del muslo, peor con cinturón y bipedestación; sin dolor lumbar.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Meralgia parestésica probable por atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral; radiculopatía L2-L3 y neuropatía femoral menos probables por ausencia de déficit motor/reflejo.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Territorio cutáneo anterolateral del muslo, sin bajar de rodilla.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Peor con compresión inguinal y extensión de cadera; mejora al aflojar ropa y sentarse.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Meralgia parestésica probable por atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral; radiculopatía L2-L3 y neuropatía femoral menos probables por ausencia de déficit motor/reflejo.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Déficit sensitivo limitado al nervio cutáneo femoral lateral; fuerza, reflejo rotuliano y aductores normales.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Prueba de tensión femoral y exploración lumbar no reproducen; cadera no explica el campo cutáneo.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Palpación/Tinel cerca de la espina iliaca anterosuperior puede reproducir, sin ser diagnóstico aislado.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.

- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Meralgia parestésica probable por atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral; radiculopatía L2-L3 y neuropatía femoral menos probables por ausencia de déficit motor/reflejo.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Meralgia parestésica probable por atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral; radiculopatía L2-L3 y neuropatía femoral menos probables por ausencia de déficit motor/reflejo.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Reducir compresión, ajustar cinturón/ropa, abordar peso y actividad; educación sobre naturaleza sensitiva del nervio.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Elegir un solo ensayo según comorbilidad: duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; o amitriptilina 10 mg por la noche, habitualmente 10-50 mg, si el riesgo anticolinérgico/intervalo QT (QT)/caídas es bajo. Gabapentina 100-300 mg nocturnos con titulación y ajuste renal, o pregabalina 25-75 mg nocturnos/75 mg cada 12 h con ajuste renal, solo cuando estén indicadas. Revisar tolerancia a 2 semanas y eficacia funcional a 4-8; retirar gradualmente si fracasa. Lidocaína tópica 5%: hasta 12 h/día en piel íntegra y zona localizada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si persiste dolor neuropático: lidocaína tópica 5% hasta 12 h/día sobre piel íntegra o duloxetina 30 mg/día y 60 mg/día si tolera; revisar y retirar si no hay beneficio funcional. Bloqueo ecoguiado diagnóstico-terapéutico seleccionado: anestésico local de bajo volumen; si se añade corticoide, usar la dosis mínima protocolizada y evitar series. Radiofrecuencia pulsada tiene evidencia limitada y requiere gobernanza.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2 semanas por tolerancia; 4-8 semanas para marcha, bipedestación, ropa y alodinia. Reabrir diagnóstico si aparece debilidad, reflejo alterado o dolor lumbar.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso En seguimiento aparece debilidad de extensión de rodilla y reflejo rotuliano reducido.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda El dato motor obliga a reabrir raíz L3-L4, plexo o nervio femoral; no repetir un bloqueo cutáneo.

Caso 31. Fractura vertebral osteoporótica frente a lumbalgia mecánica

Presentación Mujer de 78 años con osteoporosis y corticoides crónicos, dolor toracolumbar súbito al levantar una bolsa, muy focal y limitante.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Fue súbito con un esfuerzo pequeño?	Paciente: Sí, al levantar una bolsa.	Experto: Aumenta sospecha de fractura por fragilidad.
Médico: ¿Usa corticoides o le han diagnosticado osteoporosis?	Paciente: Ambos.	Experto: Probabilidad pretest alta.
Médico: ¿Debilidad, adormecimiento perineal o esfínteres?	Paciente: No.	Experto: Sin alarma neurológica actual, pero debe vigilarse.

Pensamiento del experto El contexto biológico cambia el umbral para imagen. No debo aplicar el algoritmo de lumbalgia inespecífica a un dolor súbito focal en una paciente frágil.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Aparición súbita con carga mínima.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 78 años con osteoporosis y corticoides crónicos, dolor toracolumbar súbito al levantar una bolsa, muy focal y limitante.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Fractura vertebral por fragilidad probable, sin déficit neurológico actual. Es una causa estructural que exige imagen y tratamiento de osteoporosis, no una lumbalgia facetaria rutinaria.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Localización focal toracolumbar, sin trayecto radicular.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Factores biológicos: osteoporosis, edad y corticoide sistémico.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Fractura vertebral por fragilidad probable, sin déficit neurológico actual. Es una causa estructural que exige imagen y tratamiento de osteoporosis, no una lumbalgia facetaria rutinaria.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Dolor focal a percusión vertebral y dificultad para transferencias; neurología y esfínteres documentados.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Buscar cifosis nueva, dolor costal, marcha y causas secundarias de osteoporosis.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Imagen adecuada para confirmar fractura y valorar antigüedad/compromiso; no manipular ni infiltrar antes de definirla.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.
- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Fractura vertebral por fragilidad probable, sin déficit neurológico actual. Es una causa estructural que exige imagen y tratamiento de osteoporosis, no una lumbalgia facetaria rutinaria.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Fractura vertebral por fragilidad probable, sin déficit neurológico actual. Es una causa estructural que exige imagen y tratamiento de osteoporosis, no una lumbalgia facetaria rutinaria.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Analgesia multimodal corta, movilización protegida y prevención de inmovilidad; paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h con máximo habitual 3 g/día, ajustado a fragilidad/hepatopatía.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Analgesia multimodal corta, movilización protegida y prevención de inmovilidad; paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h con máximo habitual 3 g/día, ajustado a fragilidad/hepatopatía.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si se valora antiinflamatorio no esteroideo, curso mínimo y cribado renal, gastrointestinal y cardiovascular; evitar opioide prolongado y sedación en riesgo de caída.
- Derivar para tratamiento de osteoporosis y valorar especialista espinal. Vertebroplastia/cifoplastia no son automáticas: selección por dolor refractario concordante, tiempo de evolución, imagen y guía vigente.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Contacto precoz 48-72 h si dolor no controlado; revisión 1-2 semanas de marcha, respiración, estreñimiento, caídas y neurología; plan de salud ósea y prevención secundaria.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Aparece debilidad progresiva de ambas piernas.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La evolución neurológica cambia el circuito a evaluación espinal urgente; la analgesia ambulatoria deja de ser suficiente.

Caso 32. Dolor neuropático crónico después de mastectomía

Presentación Mujer de 55 años, ocho meses tras mastectomía y vaciamiento axilar, con quemazón axilar y medial del brazo, alodinia de cicatriz y miedo a mover el hombro.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triaje obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿El roce de la ropa duele?	Paciente: Sí, incluso el sujetador es insoportable.	Experto: Alodinia neuropática.
Médico: ¿Ha notado masa, edema creciente o debilidad nueva?	Paciente: No.	Experto: Reduce, no excluye, complicación oncológica/plexual.
Médico: ¿Qué movimiento teme?	Paciente: Elevar el brazo por miedo al linfedema.	Experto: Creencia modificable que afecta función.

Pensamiento del experto No debo reducir todo a 'dolor de cicatriz'. Integro nervio lesionado, hombro, linfedema, estado oncológico, sueño y miedo al movimiento.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Inicio tras cirugía y persistencia más de tres meses.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 55 años, ocho meses tras mastectomía y vaciamiento axilar, con quemazón axilar y medial del brazo, alodinia de cicatriz y miedo a mover el hombro.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Dolor crónico posquirúrgico neuropático probable con restricción mecánica y miedo-evitación; requiere coordinación con oncología/rehabilitación y exclusión de recurrencia cuando proceda.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Localización cicatriz, axila y cara medial proximal del brazo.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Agravantes: sujetador, ropa y elevación; moduladores: miedo a linfedema y sueño.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Dolor crónico posquirúrgico neuropático probable con restricción mecánica y miedo-evitación; requiere coordinación con oncología/rehabilitación y exclusión de recurrencia cuando proceda.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Neuropático o mixto; demostrar lesión/enfermedad somatosensorial plausible.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Mapa sensitivo compatible con nervio intercostobraquial y ramas cutáneas; alodinia y pérdida sensitiva.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Explorar rango del hombro, cicatriz, cordón axilar, linfedema, plexo braquial y recurrencia tumoral.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Diferenciar dolor neuropático de capsulitis, lesión de manguito, infección o enfermedad oncológica activa.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.

- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Dolor crónico posquirúrgico neuropático probable con restricción mecánica y miedo-evitación; requiere coordinación con oncología/rehabilitación y exclusión de recurrencia cuando proceda.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Dolor crónico posquirúrgico neuropático probable con restricción mecánica y miedo-evitación; requiere coordinación con oncología/rehabilitación y exclusión de recurrencia cuando proceda.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Validación, desensibilización de cicatriz, movilidad y fuerza progresivas con fisioterapia oncológica; educación individual sobre linfedema.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Elegir un solo ensayo según comorbilidad: duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; o amitriptilina 10 mg por la noche, habitualmente 10-50 mg, si el riesgo anticolinérgico/intervalo QT (QT)/caídas es bajo. Gabapentina 100-300 mg nocturnos con titulación y ajuste renal, o pregabalina 25-75 mg nocturnos/75 mg cada 12 h con ajuste renal, solo cuando estén indicadas. Revisar tolerancia a 2 semanas y eficacia funcional a 4-8; retirar gradualmente si fracasa. Lidocaína tópica 5%: hasta 12 h/día en piel íntegra y zona localizada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Lidocaína tópica 5% hasta 12 h/día en piel íntegra o duloxetina 30 mg/día durante 1-2 semanas y 60 mg/día si tolera; medir ropa, sueño y elevación. Bloqueo periférico o plano fascial solo como ensayo seleccionado para facilitar rehabilitación; documentar anestésico local, dosis total en mg, objetivo y duración. No realizar series sin ganancia funcional.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

2 semanas por tolerancia y 6 semanas por función; vigilancia oncológica coordinada. Reabrir estudio ante masa, déficit plexual, edema progresivo o dolor nocturno nuevo.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La paciente desarrolla edema progresivo y debilidad de mano.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Los nuevos signos exigen reevaluación oncológica y del plexo; no se tratan aumentando el fármaco neuropático.

Caso 33. Opioides y polifarmacia depresora en paciente frágil

Presentación Mujer de 79 años con artrosis múltiple, oxicodona crónica, pregabalina y benzodiacepina; está somnolienta y ha sufrido dos caídas.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Qué actividad mejoró cuando subió la oxicodona?	Paciente: Ninguna claramente.	Experto: Beneficio funcional no demostrado.
Médico: ¿Se queda dormida o se ha caído?	Paciente: Dos caídas este mes.	Experto: Daño clínicamente relevante.
Médico: ¿Qué teme si reducimos?	Paciente: Que me abandonen y vuelva el dolor insoportable.	Experto: La alianza y el ritmo compartido son parte de la seguridad.

Pensamiento del experto No confundo dependencia con adicción ni convierto la retirada en castigo. Primero hago visible el daño, ofrezco alternativas y coordino un descenso que la paciente pueda sostener.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Dolor estable de años, sin nueva diana ni cambio mecánico.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Mujer de 79 años con artrosis múltiple, oxicodona crónica, pregabalina y benzodiacepina; está somnolienta y ha sufrido dos caídas.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Daño probable por polifarmacia depresora con beneficio funcional no demostrado; dependencia física posible no equivale a trastorno por uso de opioides.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Intensidad aún alta pese a escaladas; función pobre.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	ABCDE: biología de fragilidad, cognición fluctuante, discapacidad de marcha y entorno con cuidadora preocupada.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Daño probable por polifarmacia depresora con beneficio funcional no demostrado; dependencia física posible no equivale a trastorno por uso de opioides.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Nociceptivo mecánico probable, revisando componente inflamatorio, neuropático o nociplástico coexistente.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Marcha, ortostatismo, cognición, respiración, pupilas, estreñimiento y riesgo de caída.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Reconciliar todos los fármacos, dosis, prescriptores, alcohol, apnea del sueño y función renal/hepática.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	No hay déficit ni nueva articulación caliente; el problema dominante es el balance beneficio-riesgo.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.

- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Daño probable por polifarmacia depresora con beneficio funcional no demostrado; dependencia física posible no equivale a trastorno por uso de opioides.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Daño probable por polifarmacia depresora con beneficio funcional no demostrado; dependencia física posible no equivale a trastorno por uso de opioides.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

No aumentar opioide. Pactar objetivo de alerta, marcha y menos caídas; coordinar un único plan con prescriptores y cuidadora.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

No aumentar dosis. Calcular dosis equivalente de morfina, revisar benzodiacepina/gabapentinoide, apnea y función renal; ofrecer naloxona si hay riesgo. Cualquier reducción debe ser gradual, individualizada y acompañada.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

No hay una técnica indicada de entrada. Si el tratamiento base fracasa, reabrir mecanismo, diana y certeza; no convertir el fracaso conservador en indicación automática de infiltración.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Reducción gradual individualizada, nunca brusca: priorizar el fármaco de mayor riesgo y ajustar el ritmo a síntomas, función y preferencias. No ofrecer un porcentaje universal sin conocer dosis/duración.
- Ofrecer naloxona y educación cuando exista riesgo; tratar artrosis con ejercicio, ayudas, opciones tópicas/locales y comorbilidad. Si se mantiene pregabalina, ajustar a función renal y retirar gradualmente si no aporta función.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisiones frecuentes durante cambios, inicialmente 1-2 semanas: abstinencia, sedación, respiración, dolor, marcha, caídas, ánimo y adherencia; contacto urgente ante sobredosis o ideación suicida.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso La paciente rechaza una reducción rápida por miedo al abandono.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda Escuchar el miedo no significa mantener una pauta dañina. Significa construir un plan gradual, acompañado y medible.

Caso 34. Dolor lumbar inflamatorio frente a dolor mecánico

Presentación Varón de 32 años con dolor lumbar y glúteo alternante de un año, rigidez matutina prolongada y mejoría al moverse.

1. Encuadre y objetivo de la consulta

El experto no empieza interpretando la imagen. Define el problema prioritario, la actividad que el paciente quiere recuperar y el dato que obligaría a interrumpir el circuito ordinario.

Frase de apertura «Hoy quiero entender qué tipo de dolor tiene, qué le impide hacer y qué factores lo mantienen. Después pactaremos un plan por pasos y cómo sabremos si funciona».

Triage obligatorio Déficit motor nuevo/progresivo, esfínteres o anestesia perineal; fiebre/inmunosupresión/procedimiento reciente; cáncer y dolor progresivo; trauma/osteoporosis; articulación caliente; isquemia o síntomas sistémicos. Si aparece una alarma, se cambia el circuito antes de continuar.

2. Diálogo simulado: qué pregunto y qué pienso

Intervención del médico	Respuesta del paciente	Pensamiento clínico del experto
Médico: ¿Mejora al descansar o al moverse?	Paciente: Al moverme; el reposo me empeora.	Experto: Patrón inflamatorio.
Médico: ¿Le despierta y tiene que levantarse?	Paciente: Sí, en la segunda mitad de la noche.	Experto: Aumenta sospecha inflamatoria.
Médico: ¿Psoriasis, uveítis o enfermedad intestinal?	Paciente: Tuve un ojo rojo doloroso el año pasado.	Experto: Posible manifestación extraarticular; reumatología gana prioridad.

Pensamiento del experto La edad, el ritmo circadiano y la respuesta al movimiento cambian la hipótesis. No debo llamar mecánico a todo dolor lumbar ni tratar una sacroilíaca radiológica aislada.

3. ALICIA completo: la primera pasada

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
A · Aparición	¿Cuándo y cómo empezó? ¿Trauma, cirugía, brote o progresión?	Inicio insidioso antes de los 40 años.
L · Localización	Señale con un dedo dónde empieza y dibuje el mapa.	Varón de 32 años con dolor lumbar y glúteo alternante de un año, rigidez matutina prolongada y mejoría al moverse.
I · Intensidad	Actual, media y peor; ¿qué cambia en un día intenso?	Registrar escala 0-10 y, sobre todo, la actividad que deja de hacer; no inferir intensidad por conducta.

Elemento	Pregunta exacta	Registro e interpretación
C · Características	¿Presión, quemazón, descarga, rigidez, roce doloroso?	Sospecha de dolor lumbar inflamatorio/espondiloartritis axial; requiere estudio y reumatología, no infiltración facetaria por cambios incidentales.
I · Irradiación	¿Hasta dónde llega? ¿Rebasa articulación, rodilla o codo?	Dolor lumbar y glúteo alternante.
A · Agravantes/atenuantes	¿Sentarse, ponerse de pie, flexión, extensión, cama, tos, carga o estrés?	Mejora con ejercicio y empeora con reposo; antecedentes familiares y manifestaciones extraarticulares deben preguntarse.

Regla ALICIA La irradiación dibujada orienta, pero nunca localiza por sí sola una raíz. Debe converger con miotoma, reflejo, sensibilidad, prueba de tensión e imagen cuando esta vaya a cambiar la conducta.

4. ABCDE: la segunda pasada

Dominio	Pregunta nuclear	Aplicación al caso
A · Anatomía	¿Existe una diana que explica patrón, examen e imagen?	Sospecha de dolor lumbar inflamatorio/espondiloartritis axial; requiere estudio y reumatología, no infiltración facetaria por cambios incidentales.
B · Biología/mecanismo	¿Qué mecanismo y qué terreno biológico dominan?	Inflamatorio/infeccioso hasta completar el diagnóstico.
C · Cognición y curso	¿Qué cree que ocurre? ¿Qué teme? ¿Qué pasó con tratamientos previos?	Registrar expectativas, miedo, catastrofismo y discrepancias; no suponerlos si no se preguntaron.
D · Dolor y discapacidad	¿Qué actividad quiere recuperar y cómo mediremos el cambio?	Elegir una tarea: marcha, sueño, vestido, escaleras, trabajo o autocuidado; obtener valor basal.
E · Entorno	¿Qué factores familiares, laborales, económicos o de cuidados facilitan/bloquean el plan?	Definir apoyos, barreras, litigio, cuidador y acceso; si no constan, queda como dato pendiente.

5. Qué exploro, cómo lo interpreto y qué cambia

Secuencia	Maniobra/hallazgo	Cómo modifica mi decisión
Paso 1	Movilidad lumbar y expansión torácica; pruebas sacroilíacas no diagnostican por sí solas espondiloartritis.	Comprueba la hipótesis principal y busca una alternativa anatómica vecina.
Paso 2	Buscar psoriasis, uveítis, enfermedad inflamatoria intestinal, entesitis, dactilitis y artritis periférica.	Busca un déficit objetivo, un imitador o una alarma que cambie la prioridad.
Paso 3	Neurología, fiebre, pérdida de peso y factores de infección/tumor para no atribuir todo a inflamación.	Comprueba concordancia con la actividad diana y decide si una prueba adicional cambiará la conducta.

6. Diagnóstico diferencial razonado

- Alternativa anatómica vecina: comprobar que no explica mejor la actividad diana.
- Imitador neurológico, vascular, inflamatorio o sistémico según región.

- Alternativa peligrosa: documentar el dato que la hace improbable o activa su circuito.

7. Formulación del experto y grado de certeza

Sospecha de dolor lumbar inflamatorio/espondiloartritis axial; requiere estudio y reumatología, no infiltración facetaria por cambios incidentales.

Frase de cierre diagnóstico Mecanismo dominante + síndrome/diana + grado de certeza + moduladores ABCDE + alarma ausente/presente + actividad limitada.

8. Frases para explicar, implicar y crear alianza

Momento	Frase utilizable en consulta
Apertura	«Antes de hablar de pruebas o infiltraciones, quiero entender qué actividad ha perdido y qué es lo que más le preocupa».
Validación	«Le creo cuando dice que le duele. Mi trabajo ahora es identificar qué mecanismo lo mantiene y qué opción tiene una relación beneficio-riesgo razonable».
Explicación	«La hipótesis que mejor integra lo que cuenta y la exploración es esta: Sospecha de dolor lumbar inflamatorio/espondiloartritis axial; requiere estudio y reumatología, no infiltración facetaria por cambios incidentales.».
Alianza	«Acordaremos una actividad concreta y una fecha; si no mejora, revisaremos la hipótesis antes de repetir o escalar.»
Teach-back	«Cuénteme con sus palabras qué creemos que ocurre, qué hará usted, qué haremos nosotros y cuándo debe pedir ayuda».

9. Plan terapéutico estructurado

Capa 1 • Base y objetivo funcional

Mantener actividad y ejercicio; derivación/reumatología con pruebas dirigidas e imagen según criterios, sin usar un biomarcador aislado para descartar.

Capa 2 • Farmacología con dosis y regla de retirada

Si se requiere un ensayo: paracetamol 500-1.000 mg cada 8 h, máximo habitual 3 g/día y menor en fragilidad/hepatopatía; o ibuprofeno 200-400 mg cada 8 h / naproxeno 250 mg cada 12 h durante el menor tiempo posible si el riesgo renal, gastrointestinal y cardiovascular lo permite. No combinar antiinflamatorios no esteroideos.

Capa 3 • Técnica: indicación, mezcla/parámetros y propósito

Si no hay contraindicación, un antiinflamatorio no esteroideo puede servir como tratamiento: por ejemplo naproxeno 250 mg cada 12 h, ajustable según ficha y respuesta, con cribado gastrointestinal, renal y cardiovascular. No infiltrar facetas o sacroilíacas antes de definir la enfermedad inflamatoria. Tratar manifestaciones extraarticulares y escalada farmacológica con reumatología.

Capa 4 • Plan B y criterio de no repetición

- Si falla el primer escalón, volver a la formulación y decidir si hace falta otra prueba, derivación o una técnica seleccionada; no escalar por inercia.

Si no existe mejoría funcional concordante, no repetir automáticamente: revisar diagnóstico, diana, técnica, adherencia, comorbilidad y expectativas.

Seguridad de dosis Rangos docentes para adultos: verificar ficha técnica española, función renal/hepática, alergias, interacciones, concentración en mg/mL, dosis total en mg, antitrombóticos, esterilidad y protocolo institucional. Una dosis correcta no corrige una indicación incorrecta.

10. Seguimiento que dejo escrito

Revisión 4-6 semanas y seguimiento compartido: rigidez, despertares, actividad, efectos adversos y manifestaciones extraarticulares; urgencia ante ojo rojo doloroso con fotofobia o déficit neurológico.

Medir	Cuándo	Éxito	Si fracasa
Dolor + actividad diana + sueño + medicación + eventos	Ventana específica del tratamiento	Cambio funcional concordante y riesgo aceptable	No repetir automáticamente; reabrir mecanismo, diana, técnica y adherencia

11. Evolución que obliga a pensar de nuevo

Cambio del caso Aparece ojo rojo doloroso con fotofobia.

12. Reflexión del mentor

Lo que quiero que aprenda La consulta de dolor debe reconocer manifestaciones extraarticulares y activar el circuito urgente de uveítis, no limitarse a ajustar analgésicos.

Fuentes esenciales y trazabilidad

Los casos son simulados y combinan material del manual ALICIA-ABCDE con guías y literatura contrastada. Las recomendaciones sensibles deben verificarse contra la versión vigente y el protocolo institucional.

- **NICE NG193. Chronic pain: assessment and management.**
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng193/chapter/recommendations>
- **International Association for the Study of Pain (IASP) Pain Management Center Toolkit: outcomes.**
<https://www.iasp-pain.org/resources/toolkits/pain-management-center/chapter4/>
- **American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)/American Academy of Pain Medicine (AAPM)/American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP)/International Pain and Spine Intervention Society (IPSI). Corticosteroid injections in joints and soft tissue, 2025.**
<https://rapm.bmj.com/content/early/2025/03/11/rapm-2024-105656>
- **NICE NG59. Low back pain and sciatica.** <https://www.nice.org.uk/guidance/ng59/chapter/recommendations>
- **Cohen et al. Lumbar facet interventions consensus.** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32245841/>
- **American Academy of Neurology (AAN). Epidural steroid injections systematic review summary, 2025.**
<https://www.aan.com/PressRoom/home/PressRelease/5231>
- **Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids, 2022.**
<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/rr/rr7103a1.htm>
- **Budapest criteria validation for síndrome de dolor regional complejo (CRPS).**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20493633/>
- **NICE NG234. Metastatic spinal cord compression.**
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng234/chapter/recommendations>
- **Multisociety facet and articulación sacroilíaca (SI) corticosteroid recommendations, 2026.**
<https://rapm.bmj.com/content/early/2026/01/22/rapm-2025-107347>
- **Multisociety consensus on sacroiliac joint complex pain, 2025.**
<https://rapm.bmj.com/content/early/2025/11/28/rapm-2025-107387>
- **WIP Benelux. Safe use of epidural corticosteroid injections.** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7379698/>
- **NeuPSIG. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults.** <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25575710/>
- **NICE TA159. Spinal cord stimulation for chronic neuropathic pain.**
<https://www.nice.org.uk/guidance/ta159/chapter/1-Recommendations>
- **FDA. Lidocaine hydrochloride injection: maximum recommended dosages.**
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/006488s095_s090lbl.pdf
- **FDA. Bupivacaine hydrochloride injection: dosage limits and precautions.**
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/018053s061lbl.pdf
- **NICE NG197. Shared decision making.** <https://www.nice.org.uk/guidance/ng197/chapter/recommendations>

Actualización Revisar al menos anualmente dosis, antitrombóticos, indicaciones de técnicas, preparados disponibles y circuitos urgentes.